BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

QUÁCH THANH CƯỜNG

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU THUỐC

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

QUÁCH THANH CƯỜNG

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3421008

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU THUỐC

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

PGS.TS. TRẦN THĂNG LONG

NĂM 2023

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về đấu thầu thuốc.**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn: **PGS. TS. Trần Thăng Long, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.**

Tác giả: **Quách Thanh Cường** Khóa học: 28 Niên khoá: 2021-2023.

Giới thiệu: Pháp luật về đấu thầu thuốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp cung ứng thuốc trên thị trường từ đó giúp lựa chọn được nhà thầu đáp ứng các điều kiện để cung cấp thuốc đảm bảo chất lượng, số lượng với mức giá hợp lý. Sau thời gian áp dụng Luật Đấu thầu năm 2013, nhận thấy hoạt động đấu thầu thuốc có nhiều sai phạm, quy định hiện hành chưa phù hợp với sự phát triển của xã hội. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện chế định đấu thầu thuốc.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật đấu thầu thuốc. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu thầu thuốc nêu lên những điểm sáng cũng như những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về đấu thầu thuốc.

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận về pháp luật đấu thầu thuốc, người viết sử dụng phương pháp phân tích luật viết và phương pháp so sánh. Ngoài ra, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp cũng được sử dụng để tìm ra những số liệu cụ thể về đấu thầu thuốc như tỷ lệ phần trăm giữa các hình thức lựa chọn nhà thầu, tỷ lệ áp dụng sai quy định pháp luật. Cuối cùng, phương pháp logic để phân tích và đưa đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy hoạt động đấu thầu thuốc đã đóng góp không nhỏ vào tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu mua sắm công. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn còn tồn tại những hạn chế như: hình thức lựa chọn nhà thầu chưa cụ thể đối với hình thức chỉ định thầu; quy định hình thức hợp đồng trọn gói chưa phù hợp; trình tự, thủ tục tổ chức đấu thầu chưa hợp lý,… Ngoài ra, tình trạng thực hiện pháp luật không đúng với quy định pháp luật vẫn còn tồn tại. Từ đó, người viết đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về đấu thầu thuốc góp phần nâng cao hiệu quả đấu thầu thuốc.

Từ khóa: Đấu thầu thuốc, mua sắm thuốc, dược phẩm.

ABSTRACT

Subject title: **Law on drug bidding.**

Major: Economic Law Code: 8380107 Major: Law

Instructor: Assoc. Prof. PhD. Tran Thang Long, Ho Chi Minh City University of Law.

Author: Quach Thanh Cuong Course: 28 School year: 2021-2023.

Introduction: The law on drug bidding plays an crucial role in creating a healthy competitive environment among drug suppliers in the market, thereby helping to select bidder that meet the conditions to supply drugs. Quality assurance, quantity with reasonable price. After the application of the Law on Bidding in 2013, it was found that the drug bidding activity has many violations, and the current regulations are not suitable for the development of society. Therefore, it is necessary to research and come up with a solution to improve the drug procurement regulation.

Objective: To study the theoretical issues of the law on drug bidding. From the practical application of the law on drug procurement, highlight the bright spots as well as the shortcomings and limitations of the legal regulations. From there, propose solutions to improve the law on drug bidding.

Methods: To clarify the theoretical bases of the law on drug procurement, the writer uses the method of analyzing the written law and the comparative method. In addition, statistical methods and general methods are also used to find out specific data on drug procurement such as percentages between different forms of contractor selection, rate of misapplication of the law. Finally, the logical method to analyze and propose solutions contributes to the improvement of the law.

Conclusion: Through the research results, it was found that drug procurement has contributed significantly to the savings rate in public procurement. However, legal regulations still have limitations such as: the form of contractor selection is not specific to the form of contractor appointment; stipulating the form of package contract is not suitable; The order and procedures for organizing the bidding are not reasonable, etc. In addition, the situation of improper application of the law still exists. Since then, the writer has proposed solutions to improve the legal framework for drug procurement, contributing to improving the effectiveness of drug procurement.

Keywords: *Drug bidding, drug procurement, pharmaceuticals.*

MỤC LỤC

Trang

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ..... **i**

LỜI CẢM ƠN ..... **ii**

TÓM TẮT ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

LỜI CAM ĐOAN ..... **v**

MỤC LỤC ..... **vi**

DANH MỤC BẢNG ..... **viii**

DANH MỤC HÌNH ..... **ix**

LỜI MỞ ĐẦU **1**

1. Lý do chọn đề tài **1**

2. Tình hình nghiên cứu đề tài **2**

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu **4**

4. Câu hỏi nghiên cứu **4**

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu **5**

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu **5**

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn **6**

8. Kết cấu của luận văn **7**

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU THUỐC **8**

1.1 Khái quát về đấu thầu thuốc **8**

1.1.1 Khái niệm đấu thầu thuốc *8*

1.1.2 Phân loại đấu thầu thuốc *12*

1.1.3 Vai trò của đấu thầu thuốc *18*

1.2 Những nội dung cơ bản của pháp luật về đấu thầu thuốc **20**

1.2.1 Về chủ thể tham gia đấu thầu thuốc *20*

1.2.2 Hình thức lựa chọn nhà thầu *22*

1.2.3 Phương thức lựa chọn nhà thầu *24*

1.2.4 Các giai đoạn cơ bản trong đấu thầu thuốc *25*

1.3 Nguyên tắc đấu thầu thuốc **28**

1.3.1 Nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu *28*
1.3.2 Nguyên tắc đấu thầu thuốc *33*
1.4 Pháp luật về đấu thầu thuốc trên thế giới **35**
1.4.1 Quy định của Ngân hàng Thế giới *35*
1.4.2 Pháp luật đấu thầu thuốc tập trung của Trung Quốc *37*
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..... **39**
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU THUỐC **41**
2.1 Thực trạng quy định pháp luật về đấu thầu thuốc **41**
2.1.1 Thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc *41*
2.1.2 Quy định về hợp đồng *44*
2.1.3 Quy định về đấu thầu thuốc qua mạng *46*
2.1.4 Điều kiện hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu dược liệu *49*
2.1.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu *49*
2.2 Thực trạng thực hiện pháp luật **52**
2.2.1 Về trình tự, thủ tục thực hiện đấu thầu *53*
2.2.2 Việc thương thảo, bảo đảm thực hiện hợp đồng *54*
2.2.3 Xác định giá gói thầu *57*
2.2.4 Các hành vi bị cấm trong đấu thầu *60*
2.2.5 Một số vấn đề khác *63*
2.3 Kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu thầu thuốc **65**
2.3.1 Xác định đối tượng điều chỉnh phù hợp với nguồn vốn *66*
2.3.2 Quy định cụ thể trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu *66*
2.3.3 Sửa đổi quy trình đấu thầu thuốc, đấu thầu thuốc qua mạng *68*
2.3.4 Sửa đổi quy định hình thức hợp đồng trọn gói *71*
2.3.5 Tuyên truyền pháp luật và nâng cao chất lượng nhân sự đấu thầu *71*
2.3.6 Đánh giá khả năng tác động của giải pháp *72*
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..... **72**
KẾT LUẬN **74**
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO **76**
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 1.1: Phương thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc 25

Bảng 2.1: So sánh phạm vi áp dụng giữa các hình thức tổ chức đấu thầu thuốc 48

DANH MỤC HÌNH

Trang

Hình 2.1: Quy trình đấu thầu thuốc qua mạng 47

Hình 2.2: Tỷ lệ nhà thầu chi trả chi phí ngoài tham gia gói thầu tại Cơ sở y tế công lập61

Hình 2.3: Mối tương quan giữa đối xử công bằng và không chi trả chi phí ngoài theo Bên mời thầu 63

Hình 2.4: Một số hiện tượng thường gặp khi nhà thầu tham gia đấu thầu tại Cơ sở y tế công lập 64

Hình 2.5: Tỷ lệ tiết kiệm chia theo hình thức lựa chọn nhà thầu (%) 67

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày 26 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 đã chính thức thông qua Luật Đấu thầu và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2014. Trong suốt thời gian thi hành đến nay, đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động đấu thầu nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đấu thầu, đảm bảo môi trường pháp lý thống nhất và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về đấu thầu. Theo Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020 cả nước có tổng số 301.587 gói thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu (tăng 6% so với năm 2019) với tổng giá gói thầu là 958.543,726 tỷ đồng (tăng 31% tương đương với 224.962,849 tỷ đồng so với năm 2019) và tổng giá trúng thầu là 911.847,824 tỷ đồng (tăng 32% tương đương với 219.233,04 tỷ đồng so với năm 2019), chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu (giá trị tiết kiệm) là 46.697,26 tỷ đồng, tương đương 4,87% (năm 2019 tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,59%).[1] Nhìn chung, năm 2020 các gói thầu tăng cả về số lượng, quy mô. Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm của cả nước giảm nhẹ so với năm 2019, nhưng vẫn có nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đấu thầu hiệu quả, lĩnh vực Y tế có tỷ lệ tiết kiệm khá cao và chiếm 15,51%.

Tuy nhiên sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành lại bỏ ngỏ nhiều vấn đề, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Cụ thể từ khâu chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; hoạt động quản lý đấu thầu. Mỗi giai đoạn đều có những điểm hạn chế nhất định làm cho phát sinh nhiều tiêu cực, có lúc có nơi đấu thầu chỉ mang tính hình thức, ẩn chứa những điều mờ ám, thiếu minh bạch và công bằng. Do đó, ngày 27 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu trên cả nước. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu và ngày ngày 01 tháng 10 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Y tế ra Chỉ thị số 20/CT-BYT về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế.

Sau hàng loạt văn bản chấn chỉnh công tác đấu thầu được ban hành, nhưng hiệu quả hoạt động đấu thầu vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tính từ năm 2013, cơ quan quản lý đã điều tra khởi tố 11.700 vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế, trong đó có

[1] Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2021). *Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020*.

1.900 vụ án tham nhũng với 4.400 bị cáo, phần lớn liên quan đến các sai phạm về đấu thầu, mua sắm xây dựng, đầu tư công. Các vi phạm về đấu thầu diễn ra trong rất nhiều ngành khác nhau: xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục... Đặc biệt gần đây là vụ vi phạm trong đấu thầu thuốc diễn ra trên khắp cả nước[2].

Các vi phạm về đấu thầu nói chung gây hậu quả nghiêm trọng như phá vỡ kế hoạch thực hiện chi tiêu công, mua sắm công; uy tín của cơ quan Nhà nước bị giảm sút và đấu thầu thuốc nói riêng còn ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người dân. Bên cạnh đó, sau thời gian Việt Nam đấu tranh chống dịch bệnh đường hô hấp truyền nhiễm do SARS-CoV-2 (Covid-19), khoảng nửa cuối năm 2021 và trong năm 2022 tình trạng thiếu thuốc diễn ra trên khắp cả nước. Theo PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính (Bộ Y tế), cho biết thống kê với 34/63 sở y tế, 21/39 bệnh viện tuyến trung ương và 2 bệnh viện trực thuộc trường đại học cho thấy: 28/34 sở y tế báo cáo hiện có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương, 12/21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc tại đơn vị[3].

Từ những thực trạng về pháp luật đấu thầu nêu trên, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động đấu thầu thuốc nên người viết lựa chọn đề tài: ***"Pháp luật về đấu thầu thuốc"*** làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Pháp luật về đấu thầu thuốc đã được một số tác giả nghiên cứu ở các cấp độ và góc độ khác nhau. Có thể điểm qua một số công trình nghiên cứu như sau:

- Luận án Tiến sĩ dược học "Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập ở Việt Nam" của tác giả Phạm Lương Sơn – Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2012. Luận án phân tích thực trạng việc đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tại các địa phương trong năm 2010. Đánh giá các phương thức đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế nói trên từ đó đề xuất các giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện phương thức đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế ở Việt Nam.

- Luận án Tiến sĩ dược học "Hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị - Thực trạng và một số giải pháp" của tác giả Hoàng Thị Minh Hiền – Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2012. Luận án đã phân tích những ưu, nhược, bất cập chính yêu trong hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị. Giải pháp kỹ thuật trong việc quản lý thuốc độc, gây nghiện, hướng tâm thần trong kê đơn nội ngoại trú và triển khai

---

[2] Ban Nội chính Trung ương. (2020). *Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả toàn diện, thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế*. Truy cập ngày 18/12/2022, từ Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả toàn diện, thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế" - Ban Nội Chính Trung ương (noichinh.vn).

[3] Dương Liễu. (2022). *40 bệnh viện, sở y tế trên cả nước báo cáo thiếu thuốc*. Truy cập ngày truy cập 21/03/2023, từ https://tuoitre.vn/40-benh-vien-so-y-te-tren-ca-nuoc-bao-cao-thieu-thuoc-20220629190635123.htm.

hoạt động đấu thầu thuốc tại bệnh viện. Đề xuất mô hình hoạt động cho kho Dược bệnh viện và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị.

- Luận văn Thạc sĩ quản lý kinh tế "Nâng cao năng lực đấu thầu thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội" của tác giả Phạm Minh Tuấn – Trường Đại học Kinh tế năm 2016. Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về năng lực đấu thầu thuốc tại các cơ sở của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá thực trạng đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế của Công ty Hapharco trong giai đoạn 2012-2014. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế của Công ty Hapharco đến năm 2020.

- Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế "Đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh" của tác giả Nguyễn Tiến Dũng - Học viện Khoa học Xã hội năm 2021. Luận văn phân tích những vấn đề lý luận về đấu thầu mua thuốc chữa bệnh tập trung, nêu lên những thực trạng quy định pháp luật về vấn đề này và đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện được rút ra từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế "Đấu thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ theo pháp luật đấu thầu ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Lê Đức Bình - Học viện Khoa học Xã hội năm 2019. Luận văn phân tích quy định pháp luật về mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ, đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về mua sắm hàng hoá theo phương thức nêu trên.

- Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế "Trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hoá theo pháp luật về đấu thầu từ thực tiễn các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Nguyễn Thị Hương Giang - Học viện Khoa học Xã hội năm 2017. Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận các quy định của pháp luật đấu thầu về mua sắm hàng hoá, từ thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tại các đơn vị sự nghiệp công lập mà đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về trình tự mua sắm hàng hoá.

- Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế "Pháp luật về đấu thầu thuốc tại bệnh viện" của tác giả Trần Thị Thanh Tuyền – Trường Đại học Cần Thơ năm 2016. Luận văn nghiên cứu những quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu thuốc. Tìm hiểu thực trạng chung của cả nước, trên cơ sở thu thập các thông tin, số liệu, trình tự thủ tục thực hiện để đánh giá thực trạng tại bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đề xuất giải pháp giải quyết cho thực tế của địa phương.

Các công trình nghiên cứu kể trên, có những công trình nghiên cứu vấn đề cung ứng thuốc dưới góc độ dược học, quản lý kinh tế mà chưa đặt vấn đề và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu dưới góc độ luật học. Cũng có những công trình phân tích vấn

đề dưới lăng kính của luật học nhưng chỉ nghiên cứu hình thức đấu thầu chung chung, thực tiễn tại địa phương cố định, hay phân tích dưới góc độ pháp lý đã lỗi thời chưa đáp ứng nhu cầu của hiện tại. Do đó, người viết nghiên cứu đề tài *"Pháp luật về đấu thầu thuốc"* nhằm làm cầu nối, sợi dây liên hệ để cho vấn đề pháp luật về đấu thầu thuốc được nghiên cứu trọn vẹn, đầy đủ.

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật đấu thầu mua sắm thuốc. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu thầu thuốc nêu lên những điểm sáng cũng như những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc.

Mục tiêu nghiên cứu: Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tập trung vào những vấn đề sau:

- Hệ thống hoá quy định pháp luật về đấu thầu thuốc bằng sơ đồ thể hiện quy trình đấu thầu giúp người đọc dễ dàng tra cứu, tham vấn khi có nhu cầu và trở thành nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho đọc giả.

- Phân tích cơ sở lý luận, quy định pháp luật đấu thầu mua sắm thuốc: nguyên tắc mua thuốc; vai trò pháp luật; những nội dung cơ bản của pháp luật đến đấu thầu mua sắm thuốc.

- Đánh giá hoạt động áp dụng pháp luật đấu thầu mua sắm thuốc trên thực tế. Xác định những vướng mắc tồn tại trong quy trình mua sắm thuốc và chỉ rõ những nguyên nhân của bất cập, vướng mắc khi thực hiện.

- Nghiên cứu các nguyên nhân đã đề cập, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về đấu thầu thuốc.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn cần giải đáp được các câu hỏi trong quá trình nghiên cứu sau đây:

- Thế nào là thuốc và đấu thầu thuốc là gì?.

- Pháp luật đấu thầu thuốc được quy định như thế nào? Làm thế nào để tiến hành mua thuốc đúng quy định nhằm hạn chế tối đa rủi ro pháp lý về sau?.

- Sau thời gian áp dụng Luật Đấu thầu từ ngày 01/7/2014 đến nay, pháp luật đấu thầu thuốc có bộc lộ những hạn chế gì cần khắc phục hay không? Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 gây ra tình trạng thiếu thuốc diễn ra phổ biến trên khắp cả nước. Vậy có phải pháp luật đấu thầu thuốc đang là trở ngại cho việc đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời hay không hay xuất phát từ nguyên nhân khác?.

- Quy định pháp luật về đấu thầu thuốc đã được nêu từ văn bản luật, văn bản dưới luật, thậm chí ở mức độ công văn. Vậy khi áp dụng vào thực tế hoạt động mua thuốc các đơn vị mời thầu, nhà thầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan khác có tuân thủ nghiêm các quy định trên hay chưa?.

- Nếu có những điểm chưa thật sự phù hợp với tình hình xã hội thì những giải pháp căn cơ nào được đề ra nhằm khắc phục những điểm hạn chế đó để góp phần xây dựng pháp luật đấu thầu nói chung, đấu thầu thuốc nói riêng ngày càng hoàn thiện, tiệm cận với quy định của các nước phát triển, tổ chức quốc tế.

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn tập trung nghiên cứu lý thuyết chung về đấu thầu thuốc; trình tự, thủ tục đấu thầu thuốc; thực trạng các quy định pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về đấu thầu thuốc.

Phạm vi nghiên cứu: Đấu thầu là hoạt động vô cùng rộng lớn và phức tạp bao gồm quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, trong giới hạn nghiên cứu đề tài luận văn, người viết chỉ tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích quy định của pháp luật đấu thầu thuốc theo quy định Luật Đất thầu năm 2013, Luật Dược năm 2016, các văn bản hướng dẫn thi hành và so sánh với quy định về đấu thầu mua thuốc của các thông lệ quốc tế. Từ đó nêu lên những mặt còn hạn chế của quy định, những thực trạng thực hiện pháp luật nhằm đề ra những biện pháp hoàn thiện các bất cập được nêu. Trong luận văn này, người viết không phân tích cấu thành tội phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cũng như các biện pháp xử lý hành chính liên quan đấu thầu cũng như việc đấu thầu thuốc không sử dụng nguồn vốn nhà nước.

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận: Phương pháp luận Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác - Lênin là những cơ sở lý luận, là hệ tư tưởng, là kim chỉ nam giúp người viết xây dựng cách thức tiếp cận những nội dung đề tài trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm phân tích vấn đề một cách sâu sắc và thuyết phục như phương pháp thu thập thông tin, so sánh, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, chứng minh:

- Phương pháp thu thập thông tin: Luận văn tham khảo, sử dụng các thông tin đã được các tác giả khác nghiên cứu trước đó và các tài liệu chính thống được xuất bản hoặc được đăng trên các tạp chí khoa học, tài liệu nước ngoài, các sách và giáo trình được sử dụng trong các cơ sở đào tạo.

- Phương pháp so sánh: Để tìm ra được những điểm mới hoặc bất cập, người viết sử dụng phương pháp so sánh giữa các văn bản pháp luật với nhau, giữa văn bản còn hiệu lực với các văn bản hết hiệu lực. So sánh quy định pháp luật về đấu thầu thuốc của Việt Nam với quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định về đấu thầu thuốc tập trung của Trung Quốc trên cùng hệ quy chiếu. So sánh để hỗ trợ phân tích, làm rõ vấn đề, giúp nội dung luận văn được sâu sắc hơn, rút ra những kinh nghiệm quý giá nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu thầu thuốc.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Các nội dung trong luận văn chủ yếu được thực hiện bởi sự phân tích, sau đó tổng hợp lại giá trị cốt lõi nhất mà luận văn muốn đề cập đến trong từng mục, chương.

- Phương pháp diễn dịch và phương pháp quy nạp: Đi từ cái chung đến cái riêng, từ những nguyên tắc chung đến những sự việc cụ thể, hoặc từ những phân tích chi tiết đi đến kết luận. Phương pháp này được sử dụng uyển chuyển tùy từng vấn đề trong luận văn nhằm phân tích, làm rõ các quy định của pháp luật, các vấn đề xảy ra trên thực tế so với các quy định đó, đồng thời giúp cho việc đưa ra kết quả nghiên cứu được chặt chẽ, sâu sắc, cụ thể hơn.

- Phương pháp chứng minh: Để làm tăng tính thuyết phục cho luận văn, cùng với phương pháp phân tích, tổng hợp thì phương pháp chứng minh được sử dụng kết hợp để có thể làm rõ các vấn đề, đồng thời giúp người viết có thể truyền đạt thông tin một cách khoa học, khách quan và sinh động hơn.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn

Về ý nghĩa khoa học của luận văn: Thông qua hoạt động nghiên cứu các nội hàm lý luận và phân tích các quy định pháp luật về đấu thầu thuốc cũng như đưa ra các thực trạng quy định pháp luật, thực trạng thực hiện pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện những bất cập. Kết quả hoạt động nghiên cứu này đóng góp một phần cho hoạt động sửa đổi, bổ sung pháp luật đấu thầu nói chung, trong lĩnh vực đấu thầu y tế nói riêng nhằm tạo ra sự thống nhất và hoàn thiện trong các quy định về đấu thầu thuốc.

Về giá trị ứng dụng của luận văn: Luận văn là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc nên đây nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho hoạt động nghiên cứu khoa học về sau. Đồng thời, trong nội dung luận văn có hệ thống hoá quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc nên đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoạt động đấu thầu liên quan đến thuốc.

8. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài ***"Pháp luật về đấu thầu thuốc"*** được kết cấu thành 02 chương.

Chương 1: Những vấn đề lý luận về pháp luật đấu thầu thuốc.

Chương này, người viết phân tích các cơ sở lý luận nhằm làm sáng tỏ nội hàm của pháp luật về đấu thầu thuốc. Sau khi nắm rõ các vấn đề khái quát như các khái niệm có liên quan, cách thức phân loại và vai trò của đấu thầu thuốc. Người viết tiến hành trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật về đấu thầu thuốc như chủ thể tham gia, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, quy trình cơ bản của đấu thầu thuốc nhằm góp phần hệ thống hoá kiến thức và bố cục lại các quy định giúp người đọc, người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận quy định đấu thầu – đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Cuối cùng, giới thiệu quy định của Ngân hàng Thế giới về đấu thầu mua sắm thuốc cũng như khái quát pháp luật về đấu thầu thuốc tập trung của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu thầu thuốc.

Trong chương này, có 03 vấn đề lớn mà người viết đưa ra như sau: Thứ nhất, trình bày các thực trạng quy định pháp luật liên quan hoạt động đấu thầu mua thuốc. Thứ hai, nêu lên một số thực trạng thực hiện pháp luật diễn ra trong giai đoạn gần đây, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Thứ ba, từ các thực trạng quy định pháp luật đã phân tích và thực trạng thực hiện pháp luật. Người viết đưa ra một số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật đấu thầu thuốc.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU THUỐC

Trong Chương này, người viết sẽ tập trung phân tích một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu như sau: *Thứ nhất,* thế nào là thuốc và đấu thầu thuốc là gì. *Thứ hai,* khung pháp lý về đấu thầu thuốc ở Việt Nam được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật ra sao và nêu lên một số nội dung cơ bản của pháp luật về đấu thầu thuốc. *Thứ ba,* sau quá trình nghiên cứu các khái niệm và một số nội dung cơ bản của pháp luật đấu thầu thuốc tác giả rút ra một số nguyên tắc cốt lõi khi thực hiện đấu thầu thuốc. *Thứ tư,* pháp luật đấu thầu thuốc theo thông lệ quốc tế được quy định như thế nào và thông qua việc giới thiệu các quy định pháp luật đấu thầu thuốc trên Thế giới rút ra một số kinh nghiệm nhằm hoàn thiện các quy định về đấu thầu thuốc ở Việt Nam, góp phần phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

1.1 Khái quát về đấu thầu thuốc

1.1.1 Khái niệm đấu thầu thuốc

1.1.1.1Khái niệm đấu thầu

Đấu thầu là một hình thức mua bán xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử nhân loại, nó ra đời và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hoá. Thuật ngữ đấu thầu đã xuất hiện từ rất lâu trên Thế giới nhưng chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam từ cuối thập niên 80 của thế kỷ thứ XX.[4] Hiện nay, đấu thầu được một số tác giả định nghĩa như sau:

Theo tác giả Nguyễn Duy Lãm thì đấu thầu được hiểu là phương thức Nhà nước hay tư nhân sử dụng khi muốn làm một công việc, mua hoặc bán một mặt hàng nào đó, sẽ đặt giá công khai ai nhận làm, nhận mua hoặc nhận bán với giá trị có lợi nhất cho chủ thầu thì được giao cho làm công việc đó hoặc hàng đó.[5]

Theo Giáo sư Hoàng Phê thì đấu thầu được hiểu là độ công khai, ai nhận làm, nhận bán với điều kiện tốt nhất thì được giao cho làm hoặc được bán hàng (một phương thức giao làm công trình hoặc mua hàng).[6]

Theo Viện Khoa học pháp lý thì đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng một công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình, người dự thầu công bố giá mà mình muốn nhận, người gọi thầu qua so sánh để lựa chọn nhà thầu có lợi nhất cho mình theo các điều kiện do

---

[4] Võ Hoàng Quân. (2014). *Vai trò của đấu thầu đối với hiệu quả chi tiêu công.* Truy cập ngày 25/04/2023, từ https://tapchitaichinh.vn/vai-tro-cua-dau-thau-doi-voi-hieu-qua-chi-tieu-cong.html.

[5] Nguyễn Duy Lãm. (1996). *Sổ tay Thuật ngữ pháp lý thông dụng.* Hà Nội: Nxb. Giáo dục. Tr.127.

[6] Hoàng Phê. (2021). *Từ điển Tiếng Việt.* Tp. Hồ Chí Minh. Nxb: Hồng Đức. Tr.381.

mình đưa ra. Đấu thầu là phương thức được áp dụng nhằm tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp và lựa chọn đối tác để thực hiện dự án hoặc từng phần dự án.[7]

Luật Thương mại năm 2005 có định nghĩa đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu).[8]

Như vậy, thông qua các định nghĩa về đấu thầu của các tác giả kể trên có thể nhận định *đấu thầu là phương thức để thực hiện việc mua bán hay xây dựng có hai bên tham dự (bên mời thầu và bên dự thầu). Theo đó, bên mời thầu sẽ đưa ra các điều kiện và bên dự thầu sẽ đưa ra mức giá chào phù hợp nhất và tiến hành giao kết hợp đồng mua bán, xây dựng.* Tuy nhiên, nếu chỉ nhận định đấu thầu chỉ bao gồm hoạt động mua bán hàng hoá và xây dựng thì chưa thực sự điều chỉnh đầy đủ đối tượng và cũng chưa nêu lên được quy trình nghiêm ngặt của hoạt động đấu thầu.

Vì vậy, khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu có quy định: "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Đến đây, khái niệm đấu thầu dường như được hoàn thiện hơn so với các định nghĩa ở trên, phạm vi đối tượng áp được mở rộng hơn bao gồm cả các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư,… *Như vậy, có thể hiểu một cách chung nhất đấu thầu là quá trình mà bên mời thầu lựa chọn ra nhà thầu trong số các nhà thầu dự thầu đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, năng lực,… do mình đặt ra sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt để ký kết và thực hiện hợp đồng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.*

Luật Đấu thầu năm 2023 có hoàn thiện khái niệm về đấu thầu như sau: "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình". Như vậy, theo tinh thần Luật Đấu thầu năm 2023 thì đấu thầu không chỉ là quá trình bên mời thầu lựa chọn bên dự thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng mà phải bao gồm cả trách nhiệm giải trình.

---

[7] Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp. Tr.240.

[8] Khoản 1 Điều 214 Luật Thương mại năm 2005.

Đấu thầu là một tập hợp đan xen của những quan hệ kinh tế và pháp lý phức tạp. Bởi vậy, khi nghiên cứu về đấu thầu phải tiếp cận trên cả hai phương diện kinh tế và pháp lý.[9] *Về phương diện kinh tế:* Đấu thầu là quan hệ kinh tế khách quan, nó ra đời do nhu cầu tất yếu của nền kinh tế thị trường, nơi mà sản xuất và trao đổi hàng hoá luôn diễn biến trong trạng thái cung lớn hơn cầu. Khi một chủ thể nào đó có nhu cầu mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ thì cũng là lúc rất nhiều người có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Trong trường hợp này, bên mua cần tổ chức để chọn trong số người có khả năng cung cấp thỏa mãn những điều kiện của mình với giá cả hợp lý nhất. *Về phương diện pháp lý:* Đấu thầu là hành vi pháp lý của nhóm chủ thể đặc biệt trong xã hội, đấu thầu chỉ được tổ chức khi bên mời thầu có nhu cầu mua sắm hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Kết quả đấu thầu là cơ sở để xác lập hợp đồng, mặc khác hình thức pháp lý của quan hệ đấu thầu được thể hiện qua hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (sau đây gọi tắt là hồ sơ mời thầu), hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (sau đây gọi tắt là hồ sơ dự thầu) trong đó thể hiện những yêu cầu về tài chính, kỹ thuật, năng lực, mức độ đáp ứng của nhà thầu. Đây là những căn cứ pháp lý để xác lập, thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đấu thầu.

1.1.1.2 Khái niệm thuốc

Theo nghĩa rộng, thuốc bao gồm cả thuốc phòng bệnh, chữa bệnh chọn người, thuốc thú y. Đối với thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người còn có các thực phẩm chức năng, thiết bị y tế cấy ghép vào cơ thể người. Trong đó: [10]

+ Thuốc thú y là những chất hoặc hợp chất có nguồn gốc từ động vật, thực vật, vi sinh vật, khoáng chất, hoá chất được dùng để phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh hoặc để phục hồi, điều chỉnh, cải thiện chức năng của cơ thể động vật.

+ Thực phẩm chức năng là sản phẩm dùng để hỗ trợ hoạt động của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tao cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh.

+ Thiết bị y tế cấy ghép vào cơ thể người có các tiêu chuẩn sản xuất, thành phần, chất liệu khác với thuốc như: van tim nhân tạo, chỉ khâu tự thiêu,…

Theo y học thì thuốc là các phân tử thường có trọng lượng phân tử Prometi (P_M) ≤ 600. Chúng đều là các axit (acid) hoặc các bazơ (base) yếu. Kích thước phân tử của thuốc có thể thay đổi từ rất nhỏ ($P_M = 7$ như ion lithium) cho tới rất lớn (như alteplase – tPA – là protein có $P_M = 59.050$). Tuy nhiên, đa số có P_M từ 100 – 1000. Để gắn khít

[9] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2006). *Giáo trình Luật Thương mại Tập II*. Hà Nội. Nxb. Công an Nhân dân. Tr. 202.

[10] Vụ Công tác lập pháp. (2005). *Những nội dung cơ bản của Luật Dược*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp. Tr.19.

vào một loại receptor, phân tử thuốc cần đạt được một kích thước duy nhất đủ với kích thước của một receptor đặc hiệu để thuốc không gắn được vào các receptor khác (mang tính chọn lọc). Kinh nghiệm cho thấy P_M nhỏ nhất phải đạt khoảng 100 và không quá 1000, vì lớn quá thì không qua được các màng sinh học để tới nơi tác dụng.[11] Với định nghĩa này, dưới góc độ y học quan tâm đến đặc tính lý hoá của thuốc mà chưa nêu lên được nguồn gốc cũng như vai trò của thuốc.

Trong Từ điển Bách khoa dược học của tác giả Nguyễn Duy Cương cũng có đề cập tới khái niệm thuốc. Theo đó, thuốc là sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng vật hoặc vi sinh, có tác dụng dược lý, được bào chế để dùng cho người nhằm chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi hoặc điều chỉnh chức năng cơ thể, làm giảm triệu chứng bệnh, chẩn đoán bệnh, phục hồi hoặc nâng cao sức khoẻ, làm giảm cảm giác một bộ phận hoặc toàn thân làm ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ hoặc thay đổi hình dáng của cơ thể.[12] Định nghĩa này giúp phân biệt được giữa thuốc trong ngành y tế với các sản phẩm khác trong đời sống hàng ngày, phân biệt thuốc dùng trong ngành y tế với các sản phẩm không dùng cho người mà chỉ dùng cho động vật và cách tiếp cận, nhìn nhận về thuốc này gần như tương đồng với định nghĩa được quy định trong Luật Dược năm 2005.[13]

Dưới góc độ pháp lý, thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm.[14] *Như vậy, có thể hiểu thuốc là sản phẩm của quá trình điều chế các dược chất, dược liệu dùng để phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cho người*.

Dù đứng ở góc độ y học hay pháp lý thì thuốc đều được xem là loại hàng hoá đặc biệt bởi có tác dụng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của con người. Vì vậy, thuốc là mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Dược, được quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến lưu thông, phân phối nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn. Tuy nhiên, trên thị trường tồn tại nhiều loại thuốc có chất lượng thấp, hàng giả gây khó khăn cho hoạt động quản lý y tế của cơ quan chức năng. Đặc biệt là vấn đề đảm bảo thuốc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ con người trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp và tình trạng thiếu thuốc diễn ra ở hầu

---

[11] Đại học Y Hà Nội. (2007). *Dược lý học (sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa)*. Hà Nội. Tr.02.

[12] Nguyễn Duy Cương. (2005). *Từ điển Bách khoa dược học.* Hà Nội. Tr.619.

[13] Cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Luật Dược năm 2005 có định nghĩa về thuốc như sau: *"Thuốc là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, trừ thực phẩm chức năng."*

[14] Khoản 2 Điều 2 Luật Dược năm 2016.

khắp các bệnh viện trên cả nước trong thời gian vừa qua thì nhiệm vụ này cần phải được hết sức quan tâm. Vì thế, ngày 24 tháng 2 năm 2023 tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế - Bà Đào Hồng Lan đã nêu ra bảy phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của ngành y tế trong năm 2023 trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, các dự án luật, các văn bản dưới luật để tạo hành lang pháp lý cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành (như hướng dẫn triển khai Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, đấu thầu thuốc, gói dịch vụ).[15]

Qua kết quả phân tích hai khái niệm về đấu thầu và thuốc có thể đưa ra nhận định khái quát nhất về đấu thầu thuốc như sau: *"Đấu thầu thuốc là quá trình mà bên mời thầu lựa chọn ra nhà thầu cung cấp sản phẩm dùng để phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cho người trong số các nhà thầu dự thầu đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, năng lực,… do mình đặt ra sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt để ký kết và thực hiện hợp đồng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".*

1.1.2 Phân loại đấu thầu thuốc

Đấu thầu thuốc được phân chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tiêu chí sau đây:

1.1.2.1 Dựa vào hình thức lựa chọn nhà thầu

- Đấu thầu thuốc tập trung: Là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

---

[15] Hiền Minh. (2023). *Bộ trưởng Bộ Y tế nêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2023*. Truy cập ngày 25/4/2023, từ https://baochinhphu.vn/bo-truong-y-te-neu-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-y-te-nam-2023-102230224095937745.htm.

Bảy nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2023 như sau:

- Thứ nhất, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, cơ quan, đơn vị ngành y tế;

- Thứ hai, tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới;

- Thứ ba, hoàn thiện thể chế, các dự án luật, các văn bản dưới luật để tạo hành lang pháp lý cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành (như hướng dẫn triển khai Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, đấu thầu thuốc, gói dịch vụ, đặc biệt đối với trang thiết bị và hóa chất…);

- Thứ tư, nâng cao năng lực quản trị bệnh viện, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Thứ năm, các giải pháp tập trung để xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển y tế cơ sở;

- Thứ sáu, các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số;

- Thứ bảy, các giải pháp nâng cao công tác đào tạo nhân lực ngành Y tế; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực y tế.

Việc mua sắm tập trung tuân thủ các nguyên tắc được yêu cầu tại Điều 68 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như sau: *Thứ nhất,* phải được thực hiện thông qua đơn vị mua sắm tập trung thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị mua sắm tập trung không đủ năng lực thì đơn vị mua sắm tập trung thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp thực hiện việc lựa chọn nhà thầu. *Thứ hai,* đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải áp dụng mua sắm tập trung, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thỏa thuận khung và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung trên cơ sở thỏa thuận khung. Trường hợp ký kết hợp đồng với nhà thầu khác không được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung thì không được thanh toán hợp đồng. *Thứ ba,* việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với mua sắm tập trung được thực hiện theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quy định. *Thứ tư,* trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu có nội dung tương tự nhau thuộc nhiều người có thẩm quyền khác nhau, người có thẩm quyền của các gói thầu thỏa thuận, ủy quyền cho một người có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu; trong trường hợp này, người có thẩm quyền giao cho một đơn vị trực thuộc có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các trách nhiệm khác quy định tại Điều 69 của Nghị định này.

Để được áp dụng hình thức đấu thầu thuốc tập trung thì danh mục thuốc cần mua sắm phải thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT. Theo tinh thần Thông tư này, đấu thầu thuốc tập trung được chia thành hai loại. Một là, đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia. Hai là, đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương. Đối với mỗi loại đấu thầu tập trung sẽ có những quy định khác nhau về thẩm quyền, trình tự, thủ tục,… Có thể nhận định một điểm chung của hai loại đấu thầu thuốc tập trung này là đều phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc và quá trình đấu thầu này thông qua đơn vị đấu thầu chuyên nghiệp.

- Đấu thầu thuốc không tập trung: Khác với đấu thầu thuốc tập trung, với đấu thầu thuốc không tập trung thì chủ đầu tư hay đơn vị được giao dự toán mua sắm trực tiếp thực hiện đấu thầu trong khi đó đấu thầu thuốc tập trung được thực hiện thông qua một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được thành lập hợp pháp bởi cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, đấu thầu thuốc tập trung chỉ áp dụng duy nhất một hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi thì đối với đấu thầu thuốc không tập trung có thể áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

Đối với từng hình thức lựa chọn nhà thầu ra có những quy định riêng mà khi chủ đầu tư tổ chức đấu thầu phải lựa chọn đúng hình thức đã được quy định. Ví dụ như hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về

kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu hay hình thức mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Ngoài ra, mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.[16]

1.1.2.2 Dựa vào cách thức tổ chức đấu thầu thuốc

- Đấu thầu thuốc qua mạng: Là đấu thầu thuốc được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.[17] Đối với đấu thầu thuốc qua mạng hiện tại đang áp dụng lộ trình mà chưa bắt buộc 100% các gói thầu phải sử dụng cách thức này. Cụ thể như sau:

Trong năm 2023: (i) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. (ii) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. (iii) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Từ năm 2024 trở đi: (i) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch

---

[16] Điều 24 Luật Đấu thầu năm 2013.

[17] Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và quản lý theo quy định tại khoản 26 Điều 4 của Luật Đấu thầu có địa chỉ tại https://muasamcong.mpi.gov.vn.

vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. (ii) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. (iii) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Khi áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng cần lưu ý một số nguyên tắc sau: (i) Bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (ii) Bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; (iii) Đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (iv) Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

- Đấu thầu thuốc không qua mạng (đấu thầu thuốc truyền thống)

Trái ngược với đấu thầu thuốc qua mạng, đấu thầu thuốc truyền thống là đấu thầu thuốc mà không sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tổ chức đấu thầu, nghĩa là việc đấu thầu thuốc được diễn ra hoàn toàn trực tiếp giữa bên mời thầu với các nhà thầu, đơn vị, tổ chức có liên quan mà không thông qua nền tảng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Có thể lấy ví dụ minh hoạ cho hoạt động đấu thầu thuốc không qua mạng bằng hình thức đấu thầu rộng rãi với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:[18]

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Lập hồ sơ mời thầu; Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

[18] Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Mời thầu; Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; Mở thầu.

Bước 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm: Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu; Xếp hạng nhà thầu.

Bước 4. Thương thảo hợp đồng.

Bước 5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Ở đấu thầu thuốc qua mạng, trong quá trình đấu thầu tại các bước như mời thầu, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; nộp hồ sơ dự thầu; mở thầu; công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu, bên mời thầu phải thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong khi đó, ở các bước này đối với đấu thầu thuốc không qua mạng thì nhà thầu, bên mời thầu phải trực tiếp liên hệ.

Hiện nay, theo xu thế hội nhập với các thông lệ và quy định các nước trên Thế giới cũng như kết quả tích cực từ hoạt động đấu thầu thuốc qua mạng mang lại mà đấu thầu thuốc ở Việt Nam nói riêng, đấu thầu mua sắm hàng hoá nói chung đang từng bước thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm góp phần cắt giảm chi phí đấu thầu cũng như tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu.

1.1.2.3 Dựa vào việc phân chia gói thầu thuốc

- Gói thầu thuốc generic

Thuốc generic là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, dạng bào chế với biệt dược gốc và thường được sử dụng thay thế biệt dược gốc.[19] Gói thầu thuốc generic có thể có một hoặc nhiều thuốc generic, mỗi danh mục thuốc generic phải được phân chia thành các nhóm, mỗi thuốc generic trong một nhóm là một phần của gói thầu. Gói thầu thuốc generic được phân chia thành 05 (năm) tương ứng với các nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 5 ở mỗi nhóm sẽ phải đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật khác nhau.[20]

Ví dụ như nhóm 3 bao gồm các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam và được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố có chứng minh tương đương sinh học. Nhóm 4 bao gồm các thuốc được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất tại Việt Nam được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP. Nhóm 5 bao gồm các thuốc

[19] Khoản 15 Điều 2 Luật Dược năm 2016.

[20] Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam.

- Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu.[21] Các thuốc tại gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị đáp ứng đồng thời 02 (hai) tiêu chí sau:

+ Thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc và sinh phẩm tham chiếu do Bộ Y tế công bố, trừ thuốc biệt dược gốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và đã được công bố kết quả đàm phán giá.

+ Được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách Cơ quan quản lý dược chặt chẽ hoặc Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu; hoặc được sản xuất một, một số công đoạn tại Việt Nam và các công đoạn còn lại được sản xuất tại các nước thuộc danh sách Cơ quan quản lý dược chặt chẽ hoặc Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu; hoặc được sản xuất toàn bộ công đoạn tại Việt Nam; hoặc được cơ quan quản lý dược các nước thuộc danh sách Cơ quan quản lý dược chặt chẽ hoặc Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu cấp phép lưu hành.

- Gói thầu vị thuốc cổ truyền

Gói thầu vị thuốc cổ truyền có thể có một hoặc nhiều vị thuốc cổ truyền, mỗi danh mục vị thuốc cổ truyền phải được phân chia thành các nhóm, mỗi vị thuốc trong một nhóm là một phần của gói thầu. Gói thầu vị thuốc cổ truyền được phân chia thành 03 (ba) nhóm theo tiêu chí kỹ thuật như sau:[22]

+ Nhóm 1 bao gồm các vị thuốc cổ truyền được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc tại Việt Nam được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP cho vị thuốc cổ truyền và được sản xuất từ dược liệu được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GACP.

+ Nhóm 2 bao gồm các vị thuốc cổ truyền được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc tại Việt Nam được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP cho vị thuốc cổ truyền.

+ Nhóm 3 bao gồm các vị thuốc cổ truyền không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nhóm 1 và Nhóm 2 nhưng đã được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

---

[21] Biệt dược gốc là thuốc đầu tiên được cấp phép lưu hành trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả (Khoản 16 Điều 2 Luật Dược năm 2016).

[22] Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

- Gói thầu dược liệu

Gói thầu dược liệu có thể có một hoặc nhiều dược liệu, mỗi danh mục dược liệu phải được phân chia thành các nhóm, mỗi dược liệu trong một nhóm là một phần của gói thầu. Gói thầu dược liệu được phân chia thành 03 (ba) nhóm theo tiêu chí kỹ thuật như sau:[23]

+ Nhóm 1 bao gồm các dược liệu được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GACP.

+ Nhóm 2 bao gồm các dược liệu được sơ chế toàn bộ trên dây chuyền sản xuất được cơ quan quản lý dược Việt Nam công bố đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP cho nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu.

+ Nhóm 3 bao gồm các dược liệu không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nhóm 1 và Nhóm 2.

1.1.3 Vai trò của đấu thầu thuốc

- Cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng, đủ số lượng

Theo quy định của Luật Dược thì cơ sở y tế có trách nhiệm đảm bảo cung ứng đủ thuốc có chất lượng trong danh mục thuốc chủ yếu sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. Để đảm bảo được nhiệm vụ trên, cần phải có kế hoạch mua sắm thuốc rõ ràng căn cứ trên nhu cầu điều trị hợp lý, lịch sử mua sắm qua các năm,… Lập kế hoạch mua thuốc là một phần trong quy trình đấu thầu thuốc, vì vậy có thể nói thông qua đấu thầu thuốc là cơ sở để đảm bảo cung ứng thuốc chủ động, có kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Chất lượng thuốc là một trong những yếu tố quan trọng đặt lên hàng đầu trong việc sử dụng vì sự xuất hiện của thuốc giả, thuốc kém chất lượng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với tính mạng, sức khoẻ của người bệnh trong quá trình điều trị. Vấn đề thuốc không đạt chất lượng đã được Bộ Y tế rất quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản nhằm quản lý toàn diện chất lượng thuốc trên cơ sở xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về thuốc. Theo quy định tại Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc cung ứng thuốc trong bệnh viện phải thông qua danh mục thuốc thuộc danh mục thuốc của Bộ Y tế, lựa chọn và xây dựng danh mục thuốc bệnh viện là công việc đầu tiên thuộc quy trình cung ứng thuốc cho bệnh viện. Với quy định này, đã góp phần chất lượng thuốc đấu thầu đạt tiêu chuẩn, tránh tình trạng thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc giả gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân. Ngoài ra, trong đấu thầu thuốc còn có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi nhà thầu cung cấp thuốc được lựa chọn trúng thầu. Với quy định này, khi nhà thầu cung cấp thuốc

[23] Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

không đạt tiêu chuẩn như trong hồ sơ dự thầu đã cam kết thì bên mời thầu có quyền sử dụng khoản tiền trên nhằm khắc phục thiệt hại do nhà thầu gây ra.

Như vậy, hoạt động đấu thầu thuốc không chỉ đảm bảo việc cung ứng thuốc đạt được về số lượng, chủng loại thuốc theo kế hoạch được đề ra mà còn đáp ứng được điều kiện về chất lượng thuốc góp phần nâng độ tin tưởng của người bệnh vào việc sử dụng thuốc.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh

Vì đấu thầu cần công khai minh bạch, cho nên đấu thầu sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa các nhà thầu cung cấp thuốc. Đây là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược nước ta và tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Từ đó vừa phát triển các ngành sản xuất dược theo hướng chuyên môn hóa sâu và hợp tác hóa, đồng thời phát triển thị trường đấu thầu thuốc.

Thông qua đấu thầu đã phát triển được thị trường người bán, nhiều doanh nghiệp nhà thầu lớn mạnh, nhiều doanh nghiệp được thành lập mới hoặc đặt chân vào thị trường đấu thầu thuốc, đấu thầu thuốc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhà thầu, kích thích thị trường trong nước phát triển chống được sự độc quyền tự nhiên. Các chủ đầu tư, bên mời thầu cũng được tăng cường về năng lực, họ có thêm kiến thức, thông tin và trở thành những người mua ngày một thông thái hơn. Bên cạnh đó, hoạt động đấu thầu thuốc góp phần tạo động lực cho sự phát triển nhờ tăng cường sự công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và thúc đẩy cạnh tranh các hoạt động mua sắm thuốc bằng nguồn vốn của Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước

Đầu thầu nói chung, đấu thầu thuốc nói riêng là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ quản lý chi tiêu, sử dụng nguồn vốn của Nhà nước sao cho có hiệu quả và chống thất thoát, lãng phí. Luật Đấu thầu, Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cùng với pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, pháp luật về phòng - chống tham nhũng tạo thành công cụ hữu hiệu để chống lại các hành vi gian lận, tham nhũng và lãng phí trong việc chi tiêu các nguồn tiền của Nhà nước, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội nhờ thực hiện các hoạt động mua sắm thuốc theo đúng luật pháp của Nhà nước.

Việc chi tiêu, sử dụng tiền của Nhà nước thông qua đấu thầu thuốc sẽ giúp các cơ quan quản lý có điều kiện xem xét, quản lý và đánh giá một cách minh bạch các khoản chi tiêu do quá trình đấu thầu phải tuân thủ các quy trình chặt chẽ với sự tham gia của nhiều bên. Tạo điều kiện để thúc đẩy tiến trình đổi mới nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp, cơ chế "xin", "cho" sang cơ chế cạnh tranh; Thực hiện dân chủ hóa nền kinh

tế, khắc phục những nhược điểm của những thủ tục hành chính nặng nề cản trở sự năng động, sáng tạo.

Theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước có tổng số 301.587 gói thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu (tăng 6% so với năm 2019), với tổng giá gói thầu là 958.543,726 tỷ đồng (tăng 31% tương đương với 224.962,849 tỷ đồng so với năm 2019) và tổng giá trúng thầu là 911.847,824 tỷ đồng (tăng 32% tương đương với 219.233,04 tỷ đồng so với năm 2019), chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu (giá trị tiết kiệm) là 46.697,26 tỷ đồng, tương đương 4,87% (năm 2019 tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,59%). Nhìn chung, các gói thầu tăng cả về số lượng, quy mô, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách của Bộ Y tế đạt 15,51%.[24] Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023 thì cả nước đã thực hiện mua 20.137 mặt hàng thuốc với tổng giá trị 19.680.631.754.127 đồng.[25]

- Chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ giữa các quốc gia

Đấu thầu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các quốc gia, các tổ chức phát triển với các quốc gia đang phát triển. Hoạt động đấu thầu không chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp mà được diễn ra trên toàn thế giới. Các nhà thầu danh tiếng trên thế giới - họ là những người sẵn sàng và có khả năng tham gia vào tất cả các hoạt động của các quốc gia, thông qua đó họ sẵn sàng chuyển giao công nghệ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm.

Thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đấu thầu thuốc đặc biệt là hoạt động đấu thầu thuốc qua mạng giữa Việt Nam với các quốc gia đi đầu về đấu thầu qua mạng như Hàn Quốc góp phần đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý giá trong hoạt động này, xây dựng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chuẩn hoá thông tin nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch.

1.2 Những nội dung cơ bản của pháp luật về đấu thầu thuốc

1.2.1 Về chủ thể tham gia đấu thầu thuốc

- Bên mời thầu: Là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:[26]

+ Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

+ Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

---

[24] Nguyễn Thị Như Nguyệt. (2022). Thực trạng công tác đấu thầu ở Việt Nam hiện nay và khuyến nghị. *Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 01 năm 2022*, Tr.02.

[25] Cục Quản lý dược. (2023). *Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 21/04/2023*. Truy cập ngày 30/4/2023, từ https://dav.gov.vn/tong-hop-bao-cao-kqtt-cua-cac-don-vi-bao-cao-cap-nhat-den-ngay-21042023-n3929.html.

[26] Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013.

+ Đơn vị mua sắm tập trung;

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Như vậy, trong đấu thầu thuốc thì Bên mời thầu có thể bao gồm các cơ quan, tổ chức như sau: Bộ Y tế, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia và Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương (Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện,…).

- Nhà thầu: Là tổ chức hoặc cá nhân có tư cách hợp lệ đáp ứng được các yêu cầu tại Điều 5 Luật Đấu thầu, bao gồm nhà thầu chính, nhà thầu phụ, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài. Thuốc là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và đối chiếu với các quy định trong Luật Dược năm 2016, để trở thành nhà thầu cung cấp thuốc thì nhà thầu phải là các pháp nhân hợp pháp. Như vậy, kết hợp với quy định Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện như sau để trở thành nhà thầu có tư cách hợp lệ:[27]

+ Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

+ Hạch toán tài chính độc lập;

+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; (iv) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

+ Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

+ Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

- Tổ chức trung gian: Theo quy định Luật Đấu thầu, Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định bên mời thầu có quyền thuê các đơn vị tư vấn để thẩm định giá thuốc, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc lập tổ chuyên gia để đánh giá hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, trong trường hợp bên mời thầu thuê đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu thì việc lập tổ chuyên gia sẽ được thực hiện bởi đơn vị tư vấn. Vì vậy, trong

[27] Khoản 1, 2 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013.

quá trình đấu thầu thuốc ngoài bên mời thầu, nhà thầu là các chủ thể chính thì còn có sự xuất hiện của các tổ chức trung gian đóng vai trò giúp sức cho chủ thể chính thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên là các tổ chức trung gian này phải có tư cách độc lập về pháp lý và tài chính với các nhà thầu nộp hồ sơ.[28]

1.2.2 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Mục 2 Chương 3 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập thì trong đấu thầu thuốc có 06 hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện. Theo đó:

- Đấu thầu rộng rãi: Được áp dụng cho tất cả các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, trừ trường hợp được đấu thầu hạn chế, tự thực hiện. Đây được xem là hình thức đấu thầu thuốc đảm bảo tốt nhất nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Bởi lẽ, khi bên mời thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nghĩa là các thông tin về gói thầu được đăng tải công khai, việc lựa chọn danh sách nhà thầu không bị giới hạn như các hình thức chỉ định thầu, tự thực hiện,..

- Đấu thầu hạn chế: Được áp dụng trong trường hợp mua thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành và thuốc có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.[29] Đấu thầu hạn chế có nhược điểm làm giảm tính cạnh tranh, công bằng đối với các nhà thầu bởi vì đặc tính của gói thầu chỉ có một số nhà thầu mới có khả năng đáp ứng yêu cầu.

- Chỉ định thầu: Chỉ định thầu thông thường áp dụng đối với gói thầu mua thuốc để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có hạn mức không quá 01 tỷ đồng theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu; Chỉ định thầu rút gọn áp dụng đối với gói thầu thuộc các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu và Điều 79 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

---

[28] Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2013.

[29] Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt được quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm:

- Danh mục dược chất gây nghiện (Phụ lục I);

- Danh mục dược chất hướng thần (Phụ lục II);

- Danh mục tiền chất dùng làm thuốc (Phụ lục III);

- Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (Phụ lục VII).

- Chào hàng cạnh tranh: Được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu (i) Giá trị của gói thầu không quá 05 tỷ đồng; (ii) Thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành hoặc những thuốc thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật, chất lượng thuốc đã được tiêu chuẩn hóa và tương đương về chất lượng; (iii) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được người có thẩm quyền phê duyệt; (iv) Trường hợp mua từ nguồn ngân sách nhà nước thì phải có dự toán mua thuốc được phê duyệt. Trường hợp mua thuốc từ nguồn thu khác thì cơ sở y tế phải bảo đảm nguồn vốn để thanh toán theo tiến độ thực hiện gói thầu.

- Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây: (i) Nhà thầu đã trúng thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; (ii) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó. Trường hợp thuốc thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp là một trong nhiều thuốc thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì số lượng của thuốc áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% số lượng của thuốc cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó; (iii) Đơn giá của các thuốc thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các thuốc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (iv) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng. Trong thời hạn 12 tháng, cơ sở y tế chỉ được mua sắm trực tiếp một lần với mỗi mặt hàng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, trong trường hợp đặc biệt, cơ sở y tế phải có văn bản trình người có thẩm quyền quy định để xem xét, quyết định.

- Tự thực hiện: Được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và phải đáp ứng các điều kiện như sau: (i) Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; (ii) Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; (iii) Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

- Ngoài các hình thức được nêu ở trên, đối với đấu thầu thuốc còn được áp dụng hình thức đấu thầu tập trung (xem lại phần 1.1.2.1) và đàm phán giá. Thực hiện hình thức đàm phán giá đối với gói thầu mua thuốc, dược liệu chỉ có từ 01 đến 02 nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong thời gian còn bản quyền, thuốc có hàm lượng không phổ biến và trường hợp đặc thù khác.[30]

---

[30] Khoản 6 Điều 107 Luật Dược năm 2016.

Bên cạnh đó, theo tinh thần quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 thì ngoài các hình thức lựa chọn nhà thầu đã nêu trên thì đấu thầu thuốc còn được áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi không thể lựa chọn nhà thầu theo các hình thức đó, bao gồm các gói thầu sau: *(i) Gói thầu mua thuốc, vắc xin trong quá trình thử nghiệm, có yêu cầu đặc thù của nhà sản xuất về điều kiện mua, thanh toán, bảo lãnh, bảo đảm và điều kiện khác trong quá trình thực hiện hợp đồng; (ii) Gói thầu mua thuốc, vắc xin, thiết bị y tế thông qua các tổ chức quốc tế.* Để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong trường hợp đặc biệt đối với 02 gói thầu nêu trên, thì bên mời thầu phải tiến hành gửi "Văn bản đề nghị phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" đến Bộ Y tế. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do không thể đáp ứng điều kiện về lựa chọn nhà thầu đối với các hình thức khác.[31]

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập thì trong đấu thầu thuốc có 07 hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

1.2.3 Phương thức lựa chọn nhà thầu

Trong đấu thầu mua sắm hàng hoá, bên mời thầu được lựa chọn một trong bốn phương thức lựa chọn nhà thầu để tiến hành quá trình đấu thầu bao gồm phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ và phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Tuy nhiên, trong đấu thầu thuốc bên mời thầu chỉ được lựa chọn một trong hai phương thức sau: (i) phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; (ii) phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.[32]

- Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau:

+ Gói thầu mua thuốc theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng;

+ Gói thầu mua thuốc theo hình thức chào hàng cạnh tranh;

+ Gói thầu mua thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp;

+ Gói thầu mua thuốc theo hình thức chỉ định thầu thông thường.

- Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau:

---

[31] Điều 29 Luật Đấu thầu năm 2023.

[32] Mục 3 Chương 3 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

+ Gói thầu mua thuốc theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng;

+ Gói thầu mua thuốc theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng nhưng thuốc đó cần được lựa chọn trên cơ sở kết hợp giữa chất lượng và giá.

Có thể mô tả các phương thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tương ứng với các hình thức lựa chọn nhà thầu theo Bảng như sau:

Bảng 1.1 Phương thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Phương thức lựa chọn nhà thầu	**Hình thức lựa chọn nhà thầu**
Một giai đoạn một túi hồ sơ	Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng;
	Chào hàng cạnh tranh;
	Mua sắm trực tiếp;
	Chỉ định thầu thông thường.
Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng;
	Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá trị gói không quá 10 tỷ đồng nhưng cần lựa chọn trên kết hợp yếu tố giá cả và chất lượng.

1.2.4 Các giai đoạn cơ bản trong đấu thầu thuốc

Đối với từng hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau sẽ có quy trình đấu thầu thuốc khác nhau. Tuy nhiên, qua nghiên cứu quy định pháp luật hiện nay và khảo sát các gói thầu trên thực tế, có thể liệt kê các giai đoạn cơ bản trong đấu thầu thuốc như sau:

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập hàng năm hoặc khi có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu với các căn cứ từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong trường hợp cơ sở y tế đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng nhưng nhu cầu sử dụng vượt quá 20% số lượng trong hợp đồng đã ký (tính theo từng phần của gói thầu) thì cơ sở y tế phải xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của đơn vị mình.

Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo có chứa đầy đủ các nội dung như: Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà

thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng. Biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi các nội dung trên được hướng dẫn tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

Sau khi hoàn thành việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì các tổ chức được liệt kê tại khoản 15 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BYT tiến hành thẩm định trong thời hạn 20 ngày nếu được cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết và sẽ ra báo cáo thẩm định theo mẫu tại Phụ lục 6 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định và hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các chủ thể có thẩm quyền tại khoản 16 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BYT có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Bao gồm việc lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu có thể tự mình lập hồ sơ mời thầu hoặc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ. Nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong đấu thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu phải là hai chủ thể độc lập với nhau về pháp lí và tài chính.

Tuỳ theo từng phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt mà hồ sơ mời thầu phải tuân thủ theo các biểu mẫu được quy định trong Phụ lục 7, Phụ lục 8 Thông tư số 15/2019/TT-BYT. Sau khi nhận được báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu và tờ trình phê duyệt, bên mời thầu có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu bằng văn bản.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu: Trong vòng 05 ngày làm việc, bên mời thầu phải tiến hành đăng tải hồ sơ mời thầu trên báo đấu thầu hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tuỳ theo từng loại đấu thầu qua mạng hay không qua mạng). Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, bên mời thầu phải gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu. Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

+ Bảo đảm dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu: Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm với giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu, đối với gói thầu quy mô nhỏ giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu trước thời điểm đóng thầu (trừ trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu đồng) theo các hình thức sau đây: (i) Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. (ii) Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu không qua mạng, nhà thầu được lựa chọn hình thức đặt cọc, ký

quỹ; thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu của phần nhà thầu không thương thảo.

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu: Phương pháp đánh giá và thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu phụ thuộc vào tính chất, quy mô của gói thầu và hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu. Có 03 phương pháp đánh giá mà bên mời thầu có thể áp dụng như phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá đánh giá hay phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Đối với thời gian đánh giá nếu trường hợp cần thiết, có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ cung cấp thuốc cho cơ sở y tế.

+ Thương thảo hợp đồng và đề xuất trúng thầu:

Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được xếp hạng thứ nhất và được mời đến thương thảo hợp đồng.

Bên mời thầu đề xuất trúng thầu theo từng phần trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trừ gói thầu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch được giao mua sắm theo cơ số và phải đóng gói theo cơ số gồm nhiều mặt hàng thuốc thì bên mời thầu được xem xét đề xuất trúng thầu theo cơ số.

+ Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

Trong thời hạn 20 ngày (với gói thầu quy mô nhỏ trong thời hạn 10 ngày), kể từ ngày nhận đủ các tài liệu có liên quan, đơn vị tổ chức thẩm định tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình lựa chọn nhà thầu

Trong thời hạn 10 ngày (với gói thầu quy mô nhỏ trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị tổ chức thẩm định, Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo bằng văn bản kết quả lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

+ Ký hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng và sử dụng thuốc đã trúng thầu:

Sau khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng theo các điều khoản đã được quy định trong hồ sơ mời thầu và quá trình thương thảo hợp đồng. Khác với đấu thầu mua bán hàng hoá thông thường, trong đấu thầu thuốc trước thời điểm ký hợp đồng, bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm số lượng tối đa không quá 10% so với số lượng thuốc tại kế hoạch đấu thầu với điều kiện không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của hồ sơ dự thầu và hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu theo mức từ 2% đến 10% giá hợp đồng. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu theo mức từ 2% đến 3% giá hợp đồng.

Thủ trưởng cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan về hợp đồng kinh tế, phải thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết. Đối với thuốc cấp cứu, thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm soát đặc biệt, dịch truyền và những tình huống khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết. Trường hợp cơ sở y tế không thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết thì Thủ trưởng cơ sở y tế phải báo cáo, giải trình lý do với người có thẩm quyền.

1.3 Nguyên tắc đấu thầu thuốc

1.3.1 Nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu

Đấu thầu có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Đồng thời, đấu thầu cũng góp phần quản lý chi tiêu công một cách hiệu quả và minh bạch. Để thực hiện được các vai trò trên, trong hoạt động đấu thầu cần phải tuân theo các nguyên tắc nhất định. Trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, có các nguyên tắc cơ bản như sau:

- Nguyên tắc cạnh tranh: Theo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì cạnh tranh được hiểu là các hành động thể hiện nỗ lực, sự ganh đua của các tổ chức, cá nhân kinh doanh độc lập với nhau nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ do mình cung cấp với mục đích chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường.[33] Như vậy, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu có thể hiểu theo nghĩa là các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chí của doanh nghiệp đấu thầu nhằm đảm bảo

[33] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2020). *Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại (tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)*. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam. Tr.13.

sự cạnh tranh trên phạm vi rộng nhất có thể. Theo đó, Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có quy định và hướng dẫn nguyên tắc này như sau:

Thứ nhất, Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.

Thứ hai, Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với Chủ đầu tư, bên mời thầu; Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó; Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu khi đáp ứng các điều kiện: (i) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; (ii) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau; (iii) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế; (iv) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

- Nguyên tắc bảo đảm hiệu quả: Công tác đấu thầu phải đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế và thời gian, chi phí thực hiện đấu thầu không được quá cao, thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như hiệu quả của dự án. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là tìm ra nhà thầu có khả năng cung cấp hàng hoá, dịch vụ với chất lượng và giá cả tốt nhất.

Về đảm bảo hiệu quả kinh tế, khác với đấu giá, đấu thầu là tìm ra nhà thầu đưa ra mức giá càng gần với dự toán ban đầu mà vẫn đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ nhằm làm góp phần nâng cao tối đa giá trị đồng tiền. Điều này đặt ra vấn đề là bên mời thầu phải xây dựng dự toán phù hợp với nguồn vốn hiện có, các điều kiện về chất lượng hàng hoá, dịch vụ, chế độ hậu mãi (bảo hành, bảo dưỡng,…). Tuy nhiên, thực tế cho thấy chủ đầu tư, bên mời thầu chưa có sự quan tâm đúng mực về vấn đề này, cụ thể là hàng loạt các sai phạm liên quan đến việc thẩm định giá dùng làm căn cứ xây dựng dự toán gói thầu. Ngoài ra, hiệu quả kinh tế còn thể hiện ở góc độ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp. Theo Luật mẫu UNCITRAL về mua sắm công (UNCITRAL Model Law on Public Procurement) của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế thì trong mua sắm công hình thức đấu thầu rộng rãi là ưu tiên hàng đầu nhằm tăng sự cạnh tranh và tránh tình trạng chia nhỏ giá trị gói thầu để áp

dụng các hình thức kém cạnh tranh hơn như chỉ định thầu nhằm chỉ định các nhà thầu thân hữu và gây thiệt hại đến kinh tế.

Về đảm bảo hiệu quả thời gian, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải xác định thời gian thực hiện đấu thầu hợp lý tương ứng với khả năng cung cấp của nhà thầu. Nếu thời gian thực hiện gói thầu kéo dài, thì dự toán gói thầu sẽ bị nâng lên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Ví dụ điển hình là Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là dự án nhóm A do Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng (tương đương 70,5 triệu Euro), gồm nguồn vốn vay ODA Chính phủ Hungary và nguồn vốn đối ứng của địa phương. Theo đó, đã hơn 6 năm kể từ ngày được tổ chức lễ động thổ ngày 11/10/2017 đến nay dự án chỉ mới đạt 21.3% và dự án đang tạm ngưng, vật tư, thiết bị công trình chất đống ngổn ngang gây thiệt hại rất lớn.[34] Ngoài ra, đảm bảo hiệu quả thời gian còn được áp dụng trong hình thức mua sắm tập trung đây là là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung.

- Nguyên tắc minh bạch: Minh bạch là sự sẵn có thông tin liên quan và đầy đủ cho tất cả các bên có quan tâm theo một cách kịp thời và nhất quán thông qua một phương thức hiện hữu rộng khắp và sẵn sàng để tiếp cận, điều này áp dụng cho mọi khía cạnh trong hoạt động mua sắm Chính phủ, bao gồm cả môi trường vận hành chung, các cơ hội mua sắm, các yêu cầu mua sắm, các tiêu chuẩn đánh giá thầu và việc trao hợp đồng.[35] Trong thông lệ quốc tế, mà cụ thể là Hiệp định Mua sắm Chính phủ (Agreement on Government Procurement - GPA) thì minh bạch là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong mua sắm công của các quốc gia. Theo đó, có 06 nhóm yêu cầu đối với nguyên tắc này và sau khi đánh giá các quy định về tính minh bạch trong các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu có thể nhận định về tính minh bạch trong đấu thầu tại Việt Nam như sau:

+ Nhóm 1: Công bố luật và các quy định liên quan đến mua sắm chính phủ. Tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013 có quy định văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu phải được được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu, và được khuyến khích đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Rõ ràng, đối với nhóm yêu cầu này, Việt Nam đã đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của Hiệp định Mua sắm Chính phủ.[36]

---

[34] Báo điện tử Chính phủ. (2022). *Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hoàn thành sớm ngày nào bà con được hưởng lợi ngày đó*. Truy cập ngày 28/4/2023, từ https://baochinhphu.vn/benh-vien-ung-buou-can-tho-hoan-thanh-som-ngay-nao-ba-con-duoc-huong-loi-ngay-do-102220516132605384.htm.

[35] APEC. (2006). *Review of the APEC Non-Binding Principles (NBPs) on Government Procurement, Government Procurement Experts' Group Meeting*. Hoi An.

[36] Vũ Thị Hiền. (2018). Việt Nam hướng tới tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ (GPA) của WTO: Những thách thức từ góc độ minh bạch hóa. *Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 97*.

+ Nhóm 2: Xác lập kênh để tiếp nhận và xử lý các thắc mắc về luật và dự thảo luật. Hiện nay, việc tiếp nhận có thể thực hiện bằng cách nhận văn bản yêu cầu hoặc tương tác với người có yêu cầu thông qua trang web Hỏi và đáp thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, việc tương tác này chỉ bằng tiếng Việt, mà chưa thực hiện bằng tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác, khiến cho tổ chức, cá nhân đến từ các nền kinh tế khác khó tiếp cận. Do vậy, mặc dù đã đạt được mức độ đáp ứng hoàn toàn về mặt pháp lý với yêu cầu của Hiệp định Mua sắm Chính phủ nhưng vẫn cần cải thiện hơn nữa về mặt thực thi để tăng mức độ minh bạch.

+ Nhóm 3: Thông báo và diễn giải thủ tục pháp lý áp dụng đối với mua sắm chính phủ cho cá nhân từ các nền kinh tế khác. Việt Nam chưa có quy định nào và trên thực tế cũng không triển khai các hoạt động để thực hiện việc thông báo mang tính chủ động cho cá nhân của các nền kinh tế khác khi các cá nhân này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một thủ tục nào đó, thậm chí việc công bố cũng chưa rõ ràng như đối với luật và các quy định pháp lý. Xét về yêu cầu này, Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu của Hiệp định Mua sắm Chính phủ.

+ Nhóm 4: Việc tiếp cận các cơ hội đấu thầu. Việt Nam đã tương thích về cách thức thông báo mời thầu. Trong đó, Luật Đấu thầu yêu cầu đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc truy cập là miễn phí. Tuy nhiên, chưa có quy định và chưa triển khai việc thông báo ngắn gọn đối với gói thầu sắp thực hiện.

+ Nhóm 5: Công bố các yêu cầu, thông tin cần thiết trong quá trình đấu thầu (hồ sơ dự thầu, hoạt động đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng). Pháp luật Việt Nam đã cơ bản tương thích về nguyên tắc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên trong nội dung thông báo, Luật Đấu thầu không yêu cầu bắt buộc phải nêu địa chỉ của nhà thầu trúng thầu, ngày trao hợp đồng, hình thức đấu thầu, lý do áp dụng đấu thầu hạn chế như yêu cầu bởi Hiệp định Mua sắm Chính phủ.

+ Nhóm 6: Thông tin bảo mật. Luật Đấu thầu cấm tiết lộ các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật và thông tin đối với những dự án, gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Nguyên tắc công bằng: Tính công bằng ở đây được hiểu là các nhà thầu được đối xử một cách bình đẳng với nhau về nội dung thông tin được cung cấp từ chủ đầu tư, quá trình lựa chọn, đánh giá và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về nội dung thông tin được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi cung cấp thông tin về gói thầu cho nhà thầu quen như thông tin về hàng hoá, dịch vụ, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Như vậy, để đảm bảo công bằng với các nhà thầu thì chủ đầu tư phải thật khách quan, công tâm khi công bố các thông tin này đảm bảo rằng những thông

tin mà các nhà thầu nhận được đều giống nhau mà không có bất kỳ sự thiên vị hay ưu ái nào được đề ra.

Đối với tính công bằng trong quá trình lựa chọn, đánh giá và kết quả lựa chọn nhà thầu, khi lập hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.[37] Ví dụ, bên mời thầu không được nêu cụ thể về nhãn hiệu, nơi xuất xứ của hàng hoá hay đặt ra các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng mà chỉ có một hoặc rất ít nhà thầu đáp ứng được tiêu chí đó.

Luật Đấu thầu có liệt kê 10 hành vi được xem là không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu: (i) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, dự án do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư; (ii) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; (iii) Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án; (iv) Là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hoặc là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu, dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu; (v) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó; (vi) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó; (vii) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do mình giám sát; (viii) Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này; (ix) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; (x) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Trong Luật Đấu thầu năm 2023 (điểm k khoản 6 Điều 16) có bổ sung 01 hành vi *"nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 của*

[37] Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Luật này". Nhận thấy, việc bổ sung hành vi này vào nhóm không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu là hoàn toàn hợp lý bởi lẽ trên thực tế diễn ra rất nhiều hồ sơ mời thầu cố tình quy định các điều kiện hoàn toàn không hợp lý vào nhằm làm giảm sự tham gia hay tạo lợi thế cho một số nhà thầu.

1.3.2 Nguyên tắc đấu thầu thuốc

Trong đấu thầu thuốc ngoài việc phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đấu thầu như đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả đã phân tích thì Luật Đấu thầu còn có những yêu cầu riêng đối với hoạt động mua sắm thuốc phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

- Thuốc trúng thầu có mức giá hợp lý tương ứng với chất lượng, điều kiện giao hàng, bảo quản thuốc và các điều kiện liên quan khác: Giá trúng thầu của từng thuốc không được cao hơn giá của thuốc đó trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt và không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đó, trừ trường hợp có quy định khác.[38] Theo đó, Thông tư 06/2023 cũng có quy định điều chỉnh cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền *"giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc, dược liệu đó trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được công bố"* thay vào đó *"giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước hoặc trúng thầu tập trung cấp Quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được công bố trên trang Thông tin điện tử của Bộ Y tế".*[39]

Như vậy, theo tinh thần nguyên tắc của này khi lựa chọn thuốc để trúng thầu thì tổ chức tư vấn, bên mời thầu cũng phải xem xét, so sánh giữa các nhà thầu về các tiêu chí như chất lượng của thuốc, các điều kiện về giao hàng, hậu mãi về sau,… Không thể chọn nhà thầu chào giá thuốc cao hơn nhà thầu khác mà so về các tiêu chí đã trình bày thì nhà thầu này lại bằng hoặc kém hơn nhà thầu còn lại.

- Nhà thầu trúng thầu cung cấp thuốc phải bảo đảm cung cấp thuốc theo đúng các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng: Do tính chất đặc thù của thuốc là dùng để phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cho người nên việc cung cấp thuốc đảm bảo số lượng theo thoả thuận trong hợp đồng. Để đảm bảo nguyên tắc này được nghiêm túc thực hiện trên thực tế, trong quá trình đàm phán các điều kiện trong hợp đồng, bên mời thầu cần quy định các điều khoản về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhằm hạn chế tối đa việc nhà thầu thực

---

[38] Điều 36 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

[39] Điểm b khoản 13 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

hiện không đúng với thỏa thuận. Bên cạnh đó, các quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được thực hiện triệt để. Mặc dù Luật Đấu thầu cũng như các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể mức nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng, cũng như hình thức bảo đảm và điều kiện nhận lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những gói thầu mà hợp đồng không hề ràng buộc điều khoản này.

- Nhà thầu trúng thầu cung cấp thuốc phải bảo đảm thuốc đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện hợp đồng từ nguyên liệu, sản xuất, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, bàn giao thuốc: Bên cạnh việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc với mức giá phù hợp thì yếu tố chất lượng thuốc được cung cấp cũng là phần quan trọng trong các tiêu chí lựa chọn nhà thầu trúng thầu. Điều 80 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thuốc bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp.

Trong đó, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá theo thang điểm 100 hoặc 1.000 (Chất lượng thuốc: Từ 60% đến 80% tổng số điểm; Đóng gói, bảo quản, giao hàng: Từ 20% đến 40% tổng số điểm), tổng tỷ trọng điểm của 02 nội dung này bằng 100%. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có điểm về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm và điểm của từng nội dung yêu cầu về chất lượng thuốc; về đóng gói, bảo quản, giao hàng không thấp hơn 60% điểm tối đa của nội dung đó.

- Phải thực hiện mua sắm tập trung đối với những loại thuốc trong nước chưa sản xuất được, trừ những loại thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá: Nguyên tắc này đặt ra nhằm đảm bảo cân bằng trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, tránh tình trạng nhập siêu. Đồng thời, việc thực hiện mua sắm tập trung đối với những loại thuốc trong nước chưa sản xuất được góp phần giảm chi phí đấu thầu, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo được mục đích to lớn của đấu thầu là hiệu quả kinh tế.

- Đối với gói thầu mua thuốc quy mô nhỏ nhưng mặt hàng thuốc cần được lựa chọn trên cơ sở kết hợp giữa chất lượng và giá thì có thể áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ: Về nguyên tắc, đối với những gói thầu quy mô nhỏ (giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng) sẽ áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu bởi tính nhanh gọn của phương thức này so với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tuy nhiên, trong đấu thầu thuốc có nguyên tắc khi cần sự kết hợp giữa chất lượng thuốc và giá thuốc đối với những gói thầu có giá trị không quá 10 tỷ thì được phép áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Phương thức này có ưu điểm trong việc đánh giá về đề xuất kỹ thuật, theo đó, việc đánh giá này sẽ được tiến hành một cách khách quan, công bằng hơn vì việc đánh giá này không bị các

thông tin về giá dự thầu chi phối, qua đó thuận lợi cho bên mời thầu. Về bản chất, phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ sẽ giúp cho các nhà tham dự thầu giữ được bí mật giá dự thầu tại lần mở thầu đầu tiên.

1.4 Pháp luật về đấu thầu thuốc trên thế giới

1.4.1 Quy định của Ngân hàng Thế giới

- Giới thiệu chung về Tài liệu mua sắm tiêu chuẩn:

Tài liệu mua sắm tiêu chuẩn (Standard Procurement Document - SPD) áp dụng cho Hàng hóa Y tế đã được chuẩn bị để sử dụng trong các hợp đồng do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ. Tài liệu mua sắm tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng để mua sắm Hàng hóa Y tế thông qua mua sắm cạnh tranh quốc tế sử dụng hình thức đề nghị mời thầu (RFB) và áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong các dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ toàn bộ hoặc một phần, thông qua Tài trợ dự án đầu tư.

Tài liệu mua sắm tiêu chuẩn có nhiều phiên bản sửa đổi, Bản sửa đổi tháng 04 năm 2015 là phiên bản mở rộng tư cách hợp lệ của nhà thầu và Bản sửa đổi tháng 6 năm 2014 là bản chỉnh sửa những điểm không thống nhất trong các điều khoản của tài liệu và kết hợp các thay đổi theo Hướng dẫn Mua sắm Hàng hóa, Xây lắp và Dịch vụ Phi Tư vấn, ban hành vào tháng 01 năm 2011. Bản sửa đổi gần nhất là bản tháng 07 năm 2016. Theo đó, Bản sửa đổi ngày tháng 7 năm 2016 này kết hợp một số thay đổi phản ánh Quy định đấu thầu dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư. Tài liệu mua sắm tiêu chuẩn này được áp dụng cho Mua sắm hàng hóa ngành y tế do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế hoặc các dự án do Hiệp hội Phát triển Quốc tế tài trợ mà Thỏa thuận pháp lý tham chiếu đến Quy định đấu thầu dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư. Tài liệu này hướng dẫn 10 mục trong 03 nội dung chính, bao gồm: phần 1, hướng dẫn quy trình đấu thầu; phần 2, yêu cầu cung cấp và phần 3, hợp đồng.

- Hướng dẫn nhà thầu:

+ Phạm vi dự thầu: Liên quan đến Thông báo mời thầu cụ thể trong Đề nghị mời thầu (RFB) được nêu trong Bảng dữ liệu đấu thầu (BDS). Bên mời thầu phát hành tài liệu mời thầu yêu cầu cung cấp Hàng hóa (dược phẩm, vắc xin, thuốc tránh thai hoặc chất bổ sung dinh dưỡng) và các Dịch vụ liên quan kèm theo như được nêu trong Phần VII, Biểu yêu cầu.

+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu: Nhà thầu được xem có tư cách hợp lệ khi: (i) Nhà thầu có thể là một công ty tư nhân, một doanh nghiệp hoặc tổ chức thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà thầu liên danh theo một thỏa thuận hiện có hoặc với ý định tham gia vào một thỏa thuận. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên phải chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện toàn bộ Hợp đồng theo các điều khoản của Hợp đồng, các bên chỉ định 01 thành viên làm đại diện; (ii) Nhà thầu không được có xung

đột lợi ích; (iii) Một công ty là Nhà thầu (với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là thành viên Liên danh) sẽ không được tham gia nhiều hơn một Hồ sơ dự thầu, ngoại trừ các Hồ sơ dự thầu thay thế được phép. điều này bao gồm sự tham gia với tư cách là nhà thầu phụ; (iv) Một số điều kiện khác theo Tài liệu hướng dẫn.

+ Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu của mình và Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các chi phí đó, bất kể hành vi hoặc kết quả của quá trình Đấu thầu. Khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đính kèm theo các tài liệu sau: (i) Thư dự thầu được lập; (ii) Biểu giá được hoàn thiện; (iii) Bảo lãnh dự thầu hoặc Tuyên bố Bảo đảm dự thầu; (iv) Hồ sơ dự thầu thay thế; (v) Giấy uỷ quyền; (vi) Hồ sơ năng lực; (vii) Bằng chứng tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Nhà thầu; (viii) Tính hợp lệ của Hàng hóa và Dịch vụ Liên quan; (ix) Tài liệu chứng minh hàng hóa và dịch vụ liên quan phù hợp với hồ sơ mời thầu; (x) Các tài liệu khác được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

+ Giá dự thầu: Giá do nhà thầu chào sẽ được cố định trong quá trình Nhà thầu thực hiện Hợp đồng và không bị thay đổi vì bất kỳ lý do gì, trừ khi có quy định khác trong Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng Tuyên bố bảo đảm dự thầu theo mẫu hoặc một trong số loại giấy tờ theo đúng với số lượng và loại tiền được quy định trong hồ sơ mời thầu và bảo đảm dự thầu sẽ có hiệu lực trong hai mươi tám (28) ngày. Các loại giấy tờ theo hướng dẫn của hồ sơ mời thầu bao gồm: (i) một bảo lãnh vô điều kiện do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phi ngân hàng phát hành; (ii) một thư tín dụng không hủy ngang; (iii) séc được chứng nhận; hoặc một biện pháp bảo đảm khác.

- Hợp đồng:

+ Xuất xứ hàng hoá: Tất cả hàng hóa và dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng và được Ngân hàng tài trợ phải có xuất xứ tại các quốc gia đủ điều kiện. Xuất xứ có nghĩa là quốc gia nơi hàng hóa được trồng, khai thác, nuôi trồng, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến; hoặc thông qua sản xuất, xử lý hoặc lắp ráp, một sản phẩm khác được công nhận về mặt thương mại dẫn đến sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm cơ bản so với các thành phần của nó.

+ Hình thức thông báo: Bất kỳ thông báo nào do một bên đưa ra cho bên kia theo Hợp đồng phải bằng văn bản và Thông báo sẽ có hiệu lực khi được gửi hoặc vào ngày có hiệu lực của thông báo, tùy theo ngày nào đến sau.

+ Giải quyết tranh chấp: Nguyên tắc đầu tiên là giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hoà giải. Nếu sau hai mươi tám (28) ngày, các bên không giải quyết được tranh chấp một trong các bên có thể thông báo cho bên kia về ý định bắt đầu

phân xử bằng trọng tài. Trọng tài có thể được bắt đầu trước hoặc sau khi giao Hàng hóa theo Hợp đồng. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo các quy tắc tố tụng được quy định trong SCC.

Nghiên cứu kinh nghiệm về đấu thầu thuốc của Ngân hàng Thế giới có ý nghĩa rất lớn để góp phần hoàn thiện quy định về đấu thầu thuốc ở Việt Nam cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đấu thầu ở nước ta. Theo đó, Ngân hàng Thế giới xem hình thức đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu. Các hình thức khác chỉ được áp dụng khi có đầy đủ những điều kiện ràng buộc.[40]

1.4.2 Pháp luật đấu thầu thuốc tập trung của Trung Quốc

- Phạm vi áp dụng:

Theo quy định của Bộ Y tế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe công lập từ cấp quận, huyện trở lên phải mua thuốc thông qua mua sắm thuốc tập trung. Năm 2008, Trung Quốc có 15.650 bệnh viện công lập, chiếm khoảng 79% tổng số bệnh viện ở Trung Quốc. Do đó, các quy tắc của mua sắm đấu thầu tập trung (centralized bidding procurement – CBP) áp dụng cho đại đa số các bệnh viện lớn và vừa ở Trung Quốc.[41]

Theo nguyên tắc chung, các tổ chức chăm sóc sức khỏe tuân theo các quy tắc của mua sắm đấu thầu tập trung phải mua tất cả các loại thuốc mà họ sử dụng thông qua chế độ mua sắm đấu thầu tập trung, ngoại trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc phóng xạ. Với mục đích này, mỗi tỉnh ở Trung Quốc đã xây dựng danh sách thuốc mua sắm đấu thầu tập trung của riêng mình. Ngoài ra, Bộ Y tế đặt ra các ngưỡng tối thiểu về lượng thuốc mà các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải mua thông qua mua sắm đấu thầu tập trung thuốc. Các tổ chức chăm sóc sức khỏe phải lập kế hoạch liệt kê số lượng thuốc mà họ sẽ mua thông qua mua sắm đấu thầu tập trung. Số lượng của mỗi loại thuốc ít nhất phải bằng 80% số lượng thực tế mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã sử dụng trong năm trước đó. Yêu cầu này đảm bảo rằng hầu hết các loại thuốc được sử dụng bởi các tổ chức chăm sóc sức khỏe được đều được mua thông qua mua sắm đấu thầu tập trung.

- Các bên tham gia:

Chủ thể tham gia đấu thầu thuốc tập trung bao gồm: bên mời thầu, nhà thầu, đại lý mua sắm. Bên mời thầu là cơ sở y tế mua thuốc thông qua mua sắm đấu thầu tập trung. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể mua thuốc thông qua quy trình mua sắm

---

[40] Nguyễn Việt Dũng. (2012). Kinh nghiệm đấu thầu của một số tổ chức quốc tế. *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương* (317), trang 33.

[41] Chen Yang & Lei Li. (2010). *Drug Procurement Bidding*. Retrieved Mar 20, 2023, from https://www-chinabusinessreview-com.translate.goog/drug-procurement-bidding/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp.

đấu thầu tập trung thuốc cho tỉnh nơi đặt trụ sở. Nhà thầu là nhà cung cấp thuốc thường là các doanh nghiệp sản xuất thuốc, chủ thể gửi hồ sơ dự thầu cho bên mời thầu (trước năm 2009, các nhà sản xuất thuốc và nhà phân phối không phải là nhà sản xuất có thể đủ điều kiện tham gia đấu thầu). Trong hầu hết các trường hợp, bên thứ ba, đại lý thu mua trong nước điều hành quy trình đấu thầu. Bộ Y tế và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Nhà nước (SFDA) yêu cầu các đại lý thu mua phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn trước khi họ được chứng nhận cung cấp dịch vụ đại lý trong mua sắm đấu thầu tập trung thuốc.

- Quy trình đấu thầu thuốc tập trung:

Đấu thầu thuốc tập trung cho phép lựa chọn nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau nhưng cần đảm bảo hoạt động đấu thầu được diễn ra một cách cạnh tranh, công khai đối với các loại thuốc được sử dụng rộng rãi trong điều trị lâm sàng và các loại thuốc được mua sắm với số lượng lớn. Hệ thống này có thể được bổ sung bằng cách đàm phán giá tập trung cho các loại thuốc khác, nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Theo đó, quy trình đấu thầu thuốc tập trung tuân theo các thủ tục trong quy trình đấu thầu cạnh tranh điển hình, bao gồm chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng mua bán.

Tại Trung Quốc, tổng chi tiêu cho dược phẩm là 1914,90 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2018, chiếm 32,73% trong tổng chi y tế,[42] cao hơn nhiều so với mức trung bình 17% trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).[43] Để giảm bớt gánh nặng về thuốc men cho bệnh nhân đồng thời làm lành mạnh môi trường của ngành y tế, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ban hành chính sách Mua sắm thuốc tập trung quốc gia (NCDP) vào tháng 1 năm 2019.[44] Trong vòng thí điểm đầu tiên của chính sách NCDP, 04 đô thị (Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Trùng Khánh) và 7 thành phố trực thuộc tỉnh (Thẩm Dương, Đại Liên, Hạ Môn, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô và Tây An) ở Trung Quốc đã được chọn làm thành phố thí điểm, vì vậy mà thí điểm này còn được gọi là chính sách "4+7". Điểm nổi bật của chính sách "4+7" nằm ở việc triển khai "mua sắm theo số lượng lớn", trong đó lấy "giá thương mại" và "bảo đảm sử dụng" làm biện pháp cốt lõi.

Đối với "giá thương mại", mỗi cơ sở y tế công ở các thành phố thí điểm được yêu cầu nộp khối lượng mua sắm đã thỏa thuận và Cục Quản lý An ninh Y tế Quốc gia

---

[42] Zhai T *et al*. (2020). The Results and Analysis of National Health Accounts in China in 2018. *Chinese Health Economics* (39), page 5–8. DOI: 10.7664/CHE20200601.

[43] National Health Development Research Center of the National Health Commission. (2018). *2018 China Total Health Expenditure Research Report*. Beijing: Institute of health and economy press.

[44] General Office of the State Council of the People's Republic of China. (2019). *Pilot Program for National Centralized Drug Procurement and Use*. Retrieved Apr 25, 2023, from http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-01/17/content_5358604.htm.

(NHSA) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tổ chức đấu thầu cạnh tranh và đàm phán giá dựa trên tổng khối lượng mua sắm đã thỏa thuận hàng năm của 11 thành phố thí điểm. Nhà sản xuất dược phẩm có giá bỏ thầu thấp nhất trong từng loại thuốc đã trúng thầu. Kết quả đáng ngạc nhiên là trong kết quả trúng thầu, mức giảm giá bình quân của 25 sản phẩm trúng thầu là 52%.[45] Đối với "Bảo đảm sử dụng", 11 thành phố thí điểm được yêu cầu bắt đầu thực hiện kết quả trúng thầu của NHSA trước ngày 1 tháng 4 năm 2019. Việc mua tất cả các sản phẩm trúng thầu được thực hiện trên nền tảng mua sắm và đấu thầu thuốc cấp tỉnh. Bên cạnh đó, khối lượng sử dụng của từng sản phẩm trúng thầu tại từng cơ sở y tế công lập ở các thành phố thí điểm đã được NHSA kiểm tra để đảm bảo hoàn thành khối lượng mua sắm đã thỏa thuận.

- Kết quả của Chính sách "4+7":

Trong số 25 loại thuốc thuộc Danh sách "4+7", có 3 loại là biệt dược gốc của một công ty dược phẩm đã trúng thầu.[46] Sau khi thực thi chính sách, nhận thấy tỷ lệ sử dụng thuốc generic trong nhóm thuốc thuộc Danh mục '4+7' đã tăng từ 60,73% lên 77,80%; nói cách khác, 17,08% sản phẩm có thương hiệu ban đầu đã được thay thế bằng sản phẩm chung ở các thành phố thí điểm. Điều này nhìn chung phù hợp với phát hiện trước đó là 16,68% (từ 49,44% đến 66,12%) ở bốn đô thị thí điểm.[47] Bằng chứng này ủng hộ ý kiến cho rằng chính sách '4+7' đã góp phần hiệu quả vào việc sử dụng thay thế các sản phẩm cùng loại, đáng chú ý là những loại thuốc cùng loại này đã vượt qua GCE. Phân tích của DID cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong chi tiêu của các loại thuốc thuộc Danh sách '4+7' (726,40 triệu Yên mỗi tháng), cũng như các loại thuốc liên quan đến chính sách tổng thể (654,47 triệu Yên mỗi tháng), cho thấy hiệu quả chính sách nổi bật của việc tiết kiệm chi phí thuốc. Trên bình diện quốc tế, thực tiễn chính sách khả thi đối với các nước đang phát triển là đạt được mục tiêu kiềm chế chi phí dược phẩm thông qua thay thế thuốc gốc, 18–20 và hiệu quả tương tự đã được thể hiện ở Trung Quốc khi thực hiện chính sách '4+7'.[48]

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Tóm lại, thuốc là hàng hoá vô cùng quan trọng đối với hệ thống y tế của mỗi quốc gia và việc tổ chức đấu thầu thuốc mang lại nhiều ý nghĩa hết sức to lớn. Thông qua việc phân tích tường minh nội hàm về đấu thầu và thuốc đứng từ góc độ y học đến

---

[45] Joint Procurement Office. (2018). *The results of 4+7 city drug centralized procurement*. Retrieved Apr 25, 2023, from http://www.smpaa.cn/gjsdcg/2018/12/07/8531.shtml.

[46] Joint Procurement Office. (2018). *Bid-winning results of "4+7" city centralized drug procurement*. Retrieved Apr 19, 2023, from http://www.smpaa.cn/gjsdcg/2018/12/17/8580.shtml.

[47] Xie J *et al*. (2021). The influences of national centralized drug procurement policy on drug price, cost and generic drug substitution: taking the four municipalities data. *Chinese Health Economics* (40), page. 18.

[48] Wang J *et al*. (2021). Impact of '4+7' volume-based drug procurement on the use of policy-related original and generic drugs: a natural experimental study in China. *Health policy Original research*, page 8. DOI:10.1136/ BMJOPEN-2021-054346.

pháp lý, cũng như những nội dung cơ bản của pháp luật về đấu thầu thuốc như chủ thể tham gia, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, các giai đoạn cơ bản và những nguyên tắc cần được tôn trọng trong đấu thầu thuốc.

Ngoài ra, việc tìm hiểu quy định về Tài liệu mua sắm tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới áp dụng cho hàng hoá y tế có ý nghĩa tham khảo trong việc xây dựng hành lang pháp lý về đấu thầu thuốc ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu quy định về đấu thầu thuốc tập trung của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng giới thiệu được thành tựu của việc thay đổi hình thức đấu thầu thuốc nhằm giúp cho công tác đấu thầu thuốc đạng hiệu quả cao. Từ những cơ sở lý luận nêu trên, Tác giả vận dụng để việc đánh giá quy định về đấu thầu thuốc tại Chương 2 đạt chất lượng.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU THUỐC

Thuốc, dược liệu và trang thiết bị y tế là các mặt hàng tối quan trọng trong các cơ sở khám chữa bệnh, góp phần vào hiệu quả quá trình điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đấu thầu, mua sắm tại các cơ sở y tế còn một số khó khăn, vướng mắc vì đây là mặt hàng đặc thù cả về mặt khách quan và chủ quan. Cần nghiên cứu quy định pháp luật về đấu thầu thuốc một cách kỹ càng từ đó nêu lên những điểm đã đạt được của các quy định cũng như đưa ra các bất cập, những điểm chưa phù hợp cần hoàn thiện. Ngoài ra, cũng cần đi vào nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật đấu thầu thuốc diễn ra trên thực tế có đúng hay không. Thông qua việc nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về đấu thầu thuốc.

2.1 Thực trạng quy định pháp luật về đấu thầu thuốc

Qua gần 10 năm thực hiện Luật Đấu thầu (giai đoạn từ năm 2014 đến nay), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu. Trong đó, các văn bản hướng dẫn liên quan đấu thầu thuốc được cập nhật xuyên suốt nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc thực thi quy định của pháp luật đấu thầu thuốc và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, sau thời gian dài áp dụng các quy định về đấu thầu nhận thấy pháp luật đấu thầu, đặc biệt là pháp luật về đấu thầu thuốc còn những điểm hạn chế, thiếu sót liên quan xác định nguồn vốn mua sắm thuốc, các hình thức lựa chọn nhà thầu chưa quy định rõ ràng, quy định về hình thức hợp đồng chưa thực sự phù hợp với thực tế, các quy định về đấu thầu thuốc qua mạng,…

2.1.1 Thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

- Xác định nguồn vốn khi lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đối với việc quy định nguồn vốn áp dụng đấu thầu thuốc đã được các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập quy định.

Cả 03 văn bản nêu trên đều xác định phạm vị điều chỉnh của mình bao gồm *"Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập".* Như vậy, theo quy định pháp luật về đấu thầu thuốc hiện nay thì việc quy định về lựa chọn nhà thầu đối với nguồn quỹ bảo hiểm y tế không có sự khác biệt với nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn sẵn có của cơ sở khám, chữa bệnh có bản chất hoàn toàn khác biệt so với nguồn từ quỹ bảo hiểm y tế cụ thể như sau:

+ Mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn sẵn có của cơ sở khám, chữa bệnh: Cơ sở khám, chữa bệnh có nguồn kinh phí xác định trước – đóng vai trò là chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu.

+ Mua sắm từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế: Cơ sở khám, chữa bệnh không có sẵn nguồn quỹ bảo hiểm y tế vì việc thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế chỉ diễn ra sau khi sử dụng dịch vụ y tế thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế cho người bệnh và được cơ quan Bảo hiểm xã hội giám định và thực hiện chi trả. Do vậy, việc quy định cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện vai trò chủ đầu tư để lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật đấu thầu thuốc hiện tại là chưa thực sự phù hợp đối với trường hợp gói thầu có sử dụng vốn từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

Bởi lẻ, theo quy định hiện hành thì *"Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án"*. Nếu đối chiếu với khái niệm nêu trên, thì đối với trường hợp đấu thầu thuốc có sử dụng nguồn vốn từ quỹ bảo hiểm y tế thì cơ sở khám, chữa bệnh không đáp ứng trở thành chủ thể là "Chủ đầu tư" nhưng pháp luật đấu thầu lại quy định chung với đấu thầu thuốc từ nguồn ngân sách nhà nước. nguồn sẵn có của cơ sở khám, chữa bệnh là không hợp lý.

- Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc:

Luật Đấu thầu quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tại Điều 12. Theo đó, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu; thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu; thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Đối với gói thầu có quy mô nhỏ, Luật

Đấu thầu trao quyền cho Chính phủ quyết định thời gian lựa chọn nhà thầu (cụ thể được quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

Trong khi đó, các móc thời gian này khi áp dụng hình thức đấu thầu mua thuốc qua mạng được quy định như sau: Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu bên mời thầu đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT không quy định thời gian tiến hành thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu,…

Cùng với sự phát triển của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên hiện nay chủ đầu tư có thể tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu trên Hệ thống, bên mời thầu có thể phát hành ngay hồ sơ mời thầu kể từ khi đăng tải thông báo mời thầu nên một số quy định của Luật Đấu thầu về thời gian trong đấu thầu hiện không còn phù hợp bởi việc rút ngắn thời gian đấu thầu cũng như tinh giãn bớt một số công đoạn trong quá trình lựa chọn tổ chức sẽ góp phần mang lại hiệu quả của công tác đấu thầu.

Báo cáo Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ (Chính phủ, 2016) đã nêu rõ 6 đột phá mà Việt Nam cần phải thực hiện trong đó có nội dung xây dựng thể chế hiện đại và nhà nước hiệu quả.[49] Đồng thời, Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2021 đã nêu: "Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư (vốn từ khu vực tư nhân trong nước, vốn FDI, vốn ODA, vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế...) với nhiều hình thức đầu tư, đặc biệt là đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng...; nâng cao năng lực của các đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tư vấn, thiết kế giám sát; rà soát để loại bỏ ngay các nhà thầu có năng lực yếu kém". Từ những yêu cầu đặt ra như phân tích ở trên, chính sách pháp luật về đấu thầu cũng cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như cần cải tiến quy trình thủ tục đấu thầu theo hướng đơn giản hóa.

Luật Đấu thầu năm 2023 đã có những thay đổi lớn trong vấn đề này, cụ thể đã sửa đổi theo hướng rút ngắn các móc thời gian như sau: (i) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu; gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước; (ii) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày

[49] Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới. (2016). Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.

có thời điểm đóng thầu; (iii) Trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nhưng người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đồng thời, Luật cũng bổ sung những quy định về thời gian lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có quy mô nhỏ.

2.1.2 Quy định về hợp đồng

- Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói:

Điểm c khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định: *"Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói".* Điều này có nghĩa là về nguyên tắc phải ưu tiên lựa chọn hợp đồng trọn gói đối với tất cả các gói thầu trừ khi có cơ sở cho rằng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo thời gian có những điểm ưu việt hơn thì được phép lựa chọn các loại hợp đồng này. Và đặc biệt, đối với những hợp đồng mua thuốc có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ sẽ phải lựa chọn hình thức hợp đồng trọn gói mà không được áp dụng những loại hợp đồng khác. Về bản chất hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.[50]

Tính chất trọn gói ở đây được hiểu là áp dụng đối với toàn bộ số lượng thuốc nêu trong hợp đồng, điều đó có nghĩa là khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào giá trọn gói cho việc cung cấp đúng số lượng viên thuốc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu được công nhận trúng thầu với giá trúng thầu và giá hợp đồng là "A" đồng thì nhà thầu sẽ được thanh toán đúng giá trị "A" đồng nếu cung cấp cho bệnh viện đúng số lượng viên thuốc theo quy định trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của gói thầu cung cấp thuốc, số lượng thuốc sử dụng trong năm phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân nên thông thường số lượng thuốc sử dụng thực tế khác so với số lượng thuốc ghi trong hợp đồng và thực tế đã chứng minh rằng đa số hợp đồng mua sắm thuốc thì cơ sở y tế đều không hoàn thành được hết số lượng được nêu trong hợp đồng (có khi sử dụng không đạt số lượng hợp đồng hoặc sử dụng vượt số lượng trong hợp đồng). Vì vậy, hình thức

[50] Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013.

hợp đồng trọn gói đối với gói thầu mua sắm thuốc có quy mô nhỏ nói riêng và gói thầu mua sắm thuốc nói chung là chưa thực sự hợp lý.

Nhận thấy được những điểm chưa hoàn thiện trên đối với gói thầu mua sắm thuốc quy mô nhỏ, Luật Đấu thầu năm 2023 đã thay đổi quy định về hợp đồng trọn gói theo hướng *"Áp dụng đối với gói thầu mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được; gói thầu chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá nhưng các bên tham gia hợp đồng xác định được khả năng quản lý rủi ro, quản lý thay đổi phát sinh hoặc xác định được các tính chất, đặc điểm của sản phẩm đầu ra, bao gồm cả hợp đồng EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay"*[51]. Như vậy, với quy định này thì bên mời thầu có thể xem xét lựa chọn loại hợp đồng phù hợp danh mục mua sắm của mình nhằm tối ưu những thuận lợi cho quá trình đấu thầu và thanh toán.

- Thực hiện hợp đồng của cơ sở y tế:

Theo quy định về việc sử dụng thuốc đã trúng thầu tại Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT *"Thủ trưởng cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan về hợp đồng kinh tế, phải thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết. Đối với thuốc cấp cứu, thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm soát đặc biệt, dịch truyền và những tình huống khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết"* và Điều 39 *"Đơn vị đầu mối quy định tại Khoản 1 Điều 40 và Khoản 2 Điều 41 Thông tư này có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu về danh mục và số lượng thuốc của từng cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý và điều tiết việc thực hiện kế hoạch để bảo đảm sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã báo cáo về đơn vị mua thuốc tập trung. Đối với thuốc cấp cứu; thuốc giải độc; thuốc hiếm; thuốc kiểm soát đặc biệt; dịch truyền và thuốc sử dụng trong những tình huống khẩn cấp khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết"*.

Như vậy, cơ sở y tế phải cam kết sử dụng tối thiểu 80% nhu cầu thuốc theo hợp đồng. Tuy nhiên thực tế các cơ sở y tế rất khó có thể dự trù được chính xác nhu cầu sử dụng và cam kết sử dụng tối thiểu 80% thuốc đăng ký trước đó 01 đến 03 năm bởi việc sử dụng thuốc với số lượng nhiều hay ít còn tuỳ thuộc rất nhiều vào tình hình xã hội trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân. Ví dụ: sau đại dịch COVID-19, số lượng người dân đi khám, chữa bệnh tăng cao, vượt quá khả năng cung ứng dịch vụ của các cơ sở y tế. Số lượng người bệnh đến

[51] Điểm a khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu năm 2023.

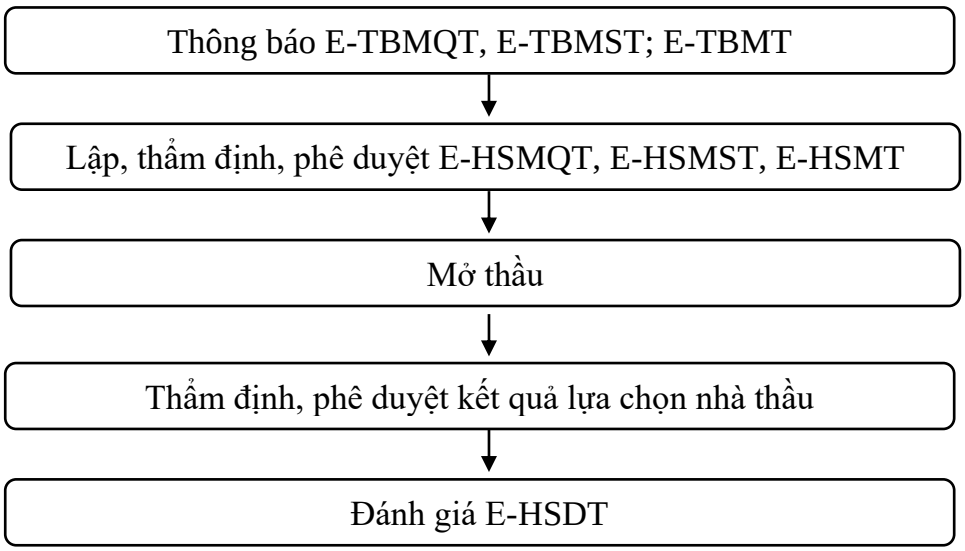
khám và điều trị tại các đơn vị y tế tăng cao so với thời gian trước đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc xác định nhu cầu và triển khai kế hoạch mua sắm thuốc của cơ sở y tế.

Với việc phải dự trù trước kế hoạch và cam kết giá trị sử dụng tối thiểu trước đó khá dài, nên có khi cơ sở y tế không thực hiện được cam kết là khả năng hoàn toàn có thể diễn ra trên thực tế. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đấu thầu chưa có chế tài xử lý cơ sở y tế không mua đủ tối thiểu 80% số lượng trong hợp đồng đã ký mà chỉ có quy định trường hợp cơ sở y tế không thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết thì Thủ trưởng cơ sở y tế phải báo cáo, giải trình lý do với người có thẩm quyền. Trong khi nhà cung cấp đã phải chuẩn bị đủ số lượng thuốc theo hợp đồng cung ứng nhằm đảm bảo cung cấp thuốc đúng số lượng, chất lượng theo hợp đồng. Mặc dù quy định chế tài xử lý cơ sở y tế khi không đáp ứng số lượng tối thiểu đã cam kết không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đấu thầu thuốc nhưng nhìn nhận theo chiều ngược lại sẽ có những ảnh hưởng đáng kể. Khi nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ số lượng thuốc theo hợp đồng (100%) nhưng cơ sở y tế chỉ sử dụng thấp hơn số lượng đã được chuẩn bị thì nhà thầu sẽ tạo tâm lý e dè và không có động lực để dự thầu ở những gói thầu tiếp theo từ đó dẫn đến số lượng nhà thầu tham gia dự thầu bị hạn chế (trong khi đó mục đích của đấu thầu là tạo môi trường cạnh tranh nhằm tìm kiếm nhà thầu đáp ứng đủ các tiêu chí) hoặc có thể nhà thầu sẽ "kê giá", liệt kê các chi phí khác nhằm bù vào khoản chi phí thất thoát do việc cơ sở y tế không thực hiện đúng hợp đồng. Kết quả của hành vi này là giá thuốc sẽ ngày càng cao do phải gánh chịu những chi phí bổ sung khác.

2.1.3 Quy định về đấu thầu thuốc qua mạng

- Quy trình đấu thầu qua mạng:

Hiện nay, Luật Đấu thầu chưa có quy định cụ thể về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu qua mạng và hiện nội dung này được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn. Thực tế căn cứ vào các tính năng cũng như lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước ban hành các Thông tư hướng dẫn đối với đấu thầu qua mạng. Cụ thể là từ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT và văn bản quy định về quy trình đấu thầu thuốc qua mạng hiện tại được áp dụng là Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Các nội dung cơ bản quy trình về đấu thầu thuốc qua mạng được quy định trong văn bản này được hệ thống hoá lại theo sơ đồ bên dưới, những nội dung không được đề cập sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật Đấu thầu:



Hình 2.1: Quy trình đấu thầu thuốc qua mạng

Trải qua hơn 10 năm áp dụng đấu thầu qua mạng, từ giai đoạn thử nghiệm đến giai đoạn áp dụng chính thức, đến nay hầu hết các khâu trong đấu thầu như đăng tải thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu lên Hệ thống, lập hồ sơ mời thầu cho các loại gói thầu, đánh giá các hồ sơ dự thầu… đều có thể thực hiện trên Hệ thống và việc áp dụng đấu thầu qua mạng đã trở nên phổ biến, ổn định và mang lại hiệu quả. Do đó, cần thiết phải quy định cụ thể quy trình thực hiện đấu thầu qua mạng trong Luật để nâng cao hiệu lực thi hành thay cho việc quy định trong các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như hiện nay.[52]

- Lộ trình áp dụng và hướng dẫn thi hành:

Theo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2023 được quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nêu cụ thể như sau: *"Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ".* Như vậy, có thể hiểu rằng bắt đầu từ ngày 01/01/2023 thì đấu thầu thuốc phải được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đối với những gói thầu có có trị không quá 200 tỷ đồng theo các hình thức lựa chọn nhà thầu đã nêu.

Tuy nhiên, tại các mẫu hồ sơ số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và mẫu hồ sơ số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai

[52] Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Đấu thầu (sửa đổi), trang 9.

đoạn hai túi hồ sơ trong phần Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của thuốc (Dành cho Bên mời thầu) tại Chương IV Biểu mẫu dự thầu, Phần 1 Thủ tục đấu thầu của E-HSMT chỉ hướng dẫn cho *"gói thầu thuốc generic; gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền"*. Sau khi so sánh, đối chiếu với các gói thầu liệt kê trong Thông tư số 15/2019/TT-BYT thì nhận thấy phạm vi điều chỉnh đấu thầu thuốc qua mạng chưa có quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với gói dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

Bảng 2.1: So sánh phạm vi áp dụng giữa các hình thức tổ chức đấu thầu thuốc

Hình thức tổ chức đấu thầu thuốc	**Phạm vi áp dụng**
Đấu thầu thuốc không qua mạng	Gói thầu thuốc generic; gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; gói thầu vị thuốc cổ truyền; gói thầu dược liệu
Đấu thầu thuốc qua mạng	Gói thầu thuốc generic; gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Hiện tại, Thông tư số 06/2023/TT-BYT đã khắc phục thiếu sót này của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT bằng cách bổ sung các Phụ lục 14 tại Phụ lục 01 và Phụ lục 15 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư.[53] Đây là hai phụ lục quy định mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Phụ lục 14) và phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Phụ lục 15).

Có thể kết luận rằng, mặc dù Thông tư số 06/2023/TT-BYT đã lấp đầy nội dung hướng dẫn về hồ sơ mời thầu qua mạng đối với tất cả các loại gói thầu mua sắm thuốc mà Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đang bị thiếu sót. Nhưng khi xét về phương diện lập pháp thì việc bổ sung 02 phụ lục này là chưa thực sự hợp lý bởi các lý do sau đây:

+ ***Thứ nhất,*** Thông tư số 06/2023/TT-BYT được ban hành chỉ nhằm mục đích là sửa đổi, bổ sung cho Thông tư số 15/2019/TT-BYT mà Thông tư này chủ yếu điều chỉnh hoạt động đấu thầu thuốc không qua mạng nhưng lại bổ sung hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc qua mạng vào văn bản này là chưa hợp lý.

+ ***Thứ hai,*** Việc quy định hồ sơ mời thầu qua mạng tại Thông tư số 06/2023/TT-BYT (hoàn toàn tách riêng với Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT). Trong khi đó, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT là văn bản quy phạm pháp luật quy định về *"Việc*

[53] Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ". Nếu xét đúng về bản chất thì phải quy định 02 mẫu hồ sơ mời thầu này tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT sẽ thuận lợi cho việc nghiên cứu, vận dụng quy định pháp luật vào thực tế. Bởi nếu theo quy định hiện hành thì không có sự thống nhất giữa các văn bản gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm thông tin.

Nhìn chung, quy định về đấu thầu thuốc qua mạng hiện nay về cơ bản đã hoàn thiện về nội dung hướng dẫn thi hành nhưng khi xét về hình thức trình bày, cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật thì chưa thực sự hoàn thiện bởi có sự quy định "xáo trộn" giữa các văn bản của các cơ quan quản lý khác nhau về đấu thầu.

2.1.4 Điều kiện hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu dược liệu

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay số lượng dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỉ trọng từ 80-85% trong tổng số dược liệu nhập khẩu của cả nước.[54] Theo quy định của quốc gia này, Cơ quan quản lý dược Trung Quốc sẽ không cấp *giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất* (GMP) mà thay bằng *giấy phép sản xuất* và căn cứ theo lộ trình áp dụng thì đến năm 2024 các giấy chứng nhận GMP sẽ không còn hiệu lực.

Tuy nhiên, tại Điều 87 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP có quy định điều kiện hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu dược liệu yêu cầu các đơn vị nhập khẩu phải xuất trình *"bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp".* Với số lượng dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc đáng kể và các quy định về điều kiện cấp phép nhập khẩu dược liệu như hiện nay thì khả năng cao nhiều doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện xuất trình giấy chứng nhận GMP do đã hết hiệu lực. Từ đó dẫn đến tình trạng độc quyền, thiếu nguồn cung đối với dược liệu trong nước và đây là một trong những nguyên nhân gây tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước theo Bộ Y tế.[55]

2.1.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Hình thức chỉ định thầu:

Hiện nay, đấu thầu thuốc có 06 hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện. Trong đó, lựa chọn hình thức chỉ định thầu đối với *gói thầu mua thuốc,*

---

[54] Báo cáo số 1528/BC-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế về thực trạng tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trang 09.

[55] Xem Phụ lục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hoá chất và trang thiết bị y tế.

hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách theo điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu là quy định còn gây nhiều tranh cãi. Thoạt nhìn quy định này dường như không có gì khó hiểu và sẽ dễ dàng áp dụng, tuy nhiên để áp dụng được quy định này trên thực tế sẽ rất khó khăn bởi trong nội hàm của quy định này chứa đựng những nội dung chưa thực sự rõ nghĩa, làm cho người trực tiếp thực thi pháp luật sẽ khó khăn, lúng túng.

Để lựa chọn hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu mua thuốc trong trường hợp này phải đáp ứng đồng thời 02 điều kiện (gói thầu có mục đích phòng, chống dịch bệnh và phải đặt trong tình thế khẩn cấp). Vấn đề đặt ra ở đây là loại dịch bệnh nào sẽ được áp dụng quy định này hay đơn thuần là tất cả các loại dịch bệnh đều được áp dụng. Vấn đề này hiện tại cũng chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn nào của Chính phủ đề cập giải thích. Ngoài ra, điều kiện thứ hai là gói thầu mua thuốc phải được đặt trong "trường hợp cấp bách" mới thoả mãn điều kiện của quy định trên. Theo nghĩa thông thường, *"cấp bách" được hiểu là tình thế rất gấp, cần được giải quyết ngay.* Tuy nhiên, việc thể hiện trong văn bản quy phạm pháp luật những từ ngữ mang tính định tính rất cao như thế này mà không có bất kỳ sự hướng dẫn nào từ phía nhà làm luật sẽ gây sự hiểu nhầm đối với người thi hành pháp luật và thực tế là trong suốt giai đoạn đầu dịch COVID-19 diễn ra ở nước ta có rất nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế hoang mang không biết áp dụng pháp luật như thế nào cho đúng trong trường hợp này (trong đó có cả Bộ Y tế). Hậu quả của việc này là đối với cùng đợt mua sắm, có gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, có gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp hoặc đấu thầu rộng rãi.

Để giải quyết bất cập nêu trên, Chính phủ đã kịp thời ban hành 02 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 86 ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, cả 02 Nghị quyết này đều thống nhất hướng dẫn *"Việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu".*

Đến nay, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi nội dung này thành *"Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong trường*

hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường".[56] Với tinh thần nội dung sửa đổi mới, Luật đấu thầu cho phép tiến hành lựa chọn hình thức chỉ định thầu mua sắm thuốc trong 03 trường hợp. *Một là,* cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách, tránh gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe người dân; *Hai là,* mua thuốc để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có đủ thuốc; Ba là, gói thầu mua thuốc chỉ có duy nhất một hãng sản xuất trên thị trường.

Như vậy, Luật Đấu thầu sửa đổi không mở rộng phạm vi được phép chỉ định thầu mua sắm thuốc mà chỉ liệt kê theo hướng chi tiết hơn so với quy định cũ (liệt kê thêm 02 trường hợp do có một hãng sản xuất trên thị trường và trong trường hợp người bệnh lâm vào tình trạng cấp cứu mà cơ sở y tế không đủ thuốc). Ngoài ra, đối với trường hợp đầu tiên cũng đã có sự thay đổi đáng kể là chỉ cần một trong hai điều kiện là gói thầu cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh *hoặc* duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong tình huống cấp bách thay vì phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện như hiện tại. Tuy nhiên, cũng tồn tại hạn chế như luật sửa đổi chưa giải thích được trường hợp nào là cấp bách để các cơ sở y tế thống nhất thực hiện cho đúng quy định. Đối với quy định này, còn phải đợi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn cụ thể bởi vì tại khoản 7 Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2023 chỉ định Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết điều khoản này.

- Đấu thầu thuốc tập trung:

Hiện nay, đấu thầu thuốc tập trung được áp dụng khi thuốc cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và với quy định này đang thể hiện bất cập nhất định đặc biệt là trước tình trạng thiếu thuốc hiếm trong thời gian qua. Một trong những trường hợp điển hình là chùm ca ngộ độc Pate Minh Chay năm 2020 hay gần đây nhất là chùm ngộ độc Botulinum ở Quảng Nam và 06 trường hợp ngộ độc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng tiếc là thuốc điều trị đặc hiệu Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) thời điểm đó trên cả nước không đáp ứng đủ số lượng và dẫn tới trường hợp tử vong (mặc dù Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới viện trợ hỏa tốc).

Nhận thấy được sự chưa hoàn thiện trong luật hiện hành, Quốc hội đã sửa đổi điều khoản về mua sắm tập trung, trong đó ngoài việc quy định mua sắm thuốc tập trung đối với những loại thuốc có số lượng lớn và nhu cầu sử dụng nhiều ở các đơn vị khác nhau thì còn bổ sung *"Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu*

[56] Điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2023.

cầu khám bệnh, chữa bệnh" vào mua sắm thuốc tập trung bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Với việc bổ sung trường hợp thuốc hiếm vào danh mục thuốc đấu thầu tập trung là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ, với nhu cầu sử dụng của từng đơn vị, ở mỗi địa phương sẽ không nhiều và số lượng nhà cung cấp trên thị trường đối với thuốc hiếm cũng không đa dạng. Vì vậy, việc giao địa phương tổ chức đấu thầu thuốc hiếm gần như là phương án khó thực hiện được. Lúc này nếu địa phương không tổ chức đấu thầu được thì tình trạng thiếu thuốc và không có thuốc điều trị bệnh lại tiếp tục diễn ra trong khi không ai lường trước được trong tương lai sẽ có thể ngăn chặn tình huống ngộ độc giống như chùm ca ngộ độc Botulinum hay những trường hợp tương tự hay không.

- Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong trường hợp đặc biệt:

Điều 26 Luật Đấu thầu cho phép *"Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư".* Quy định này chưa cụ thể cũng như nếu muốn triển khai thực hiện trên thực tế phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ. Thời giai đoạn dịch COVID-19 diễn ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 hướng dẫn kịp thời và cho phép thực hiện.

Theo đó, Nghị quyết số 79/NQ-CP ghi nhận *"Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua thông qua các đơn vị mua sắm của Liên hợp quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư".*

Như vậy, đến khi Nghị quyết số 79/NQ-CP hướng dẫn chính thức những trường hợp nào được phép tiến hành lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt để mua sắm thuốc thì mới có đủ cơ sở để tiến hành đấu thầu thuốc. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn chưa quy định trình tự, thủ tục xây dựng phương án trình thẩm định, phê duyệt, mua sắm trong trường hợp đặc biệt dẫn đến bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện.

2.2 Thực trạng thực hiện pháp luật

Nhìn chung, việc tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc chưa đạt được hiệu quả cao trong thời gian qua có phần nào các quy định pháp luật về đấu thầu thuốc còn chưa cập nhật kịp với tình hình xã hội cũng như các quy định của thế giới về mua sắm công. Bên cạnh đó, một phần không nhỏ là do việc thực hiện các quy định pháp luật vào thực

tế các gói thầu ở mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi cơ sở khám, chữa bệnh chưa có sự nhất quán theo đúng yêu cầu của quy định pháp luật mặc dù các trường hợp này pháp luật về đấu thầu thuốc đã dự liệu và đã có những quy định cụ thể, chặt chẽ.

2.2.1 Về trình tự, thủ tục thực hiện đấu thầu

- Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn:

Luật Đấu thầu đã có những quy định cho phép thực hiện chỉ định thầu trong những trường hợp gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách. Bên cạnh đó, các Nghị quyết của Chính phủ như Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV đều xác định rằng *"việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu".*

Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra tại Thành phố Hồ Chí Minh đại đa số các gói thầu được kiểm tra được các chủ đầu tư lựa chọn hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn để lựa chọn nhà thầu, một số ít chủ đầu tư lựa chọn hình thức mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi. Theo đó, tất cả các chủ đầu tư của các gói thầu kiểm tra chưa làm đúng quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu, khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư số 56/2016/TT-BTC dẫn tới kéo dài thời gian mua sắm, không đáp ứng được tính cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Công bố thông tin đấu thầu:

Việc công bố thông tin đấu thầu cũng là một trong những trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu. Theo đó, bên mời thầu phải tiến hành cung cấp kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng như thông báo mời thầu, Thông báo mời chào hàng; Thông báo mời quan tâm, Thông báo mời sơ tuyển; Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia hoặc Báo đấu thầu.[57] Tương ứng với mỗi loại thông tin cần công bố sẽ có những mốc thời gian, quy trình, cách thức đăng tải phù hợp với quy định của pháp luật.

Ví dụ: Đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để việc công bố thông tin đúng theo quy định thì bên mời thầu phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian không muộn hơn 07 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành.

Trên thực tế, qua cuộc khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về quá trình thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm công tại địa phương do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam có 23% nhà thầu tham gia các gói thầu của các cơ sở y tế công lập cho rằng Thông báo mời thầu của bên mời thầu không được công bố rộng rãi.[58] Ngoài ra, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ thì có một số chủ đầu tư không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu. Từ đó làm hạn chế các thông tin về giá trúng thầu để các cơ quan, đơn vị tham khảo, đối chiếu xây dựng giá gói thầu (như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Trưng Vương,…).

Hay nghiệm trọng hơn là trường hợp gói thầu mua vắc xin Abdala của Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế đã bỏ qua thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo khoản 1 Điều 66 Luật Đấu thầu. Theo đó, *vào ngày 20/9/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất với nội dung Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.* Và cho dù gói thầu áp dụng theo bất kỳ hình thức lựa chọn nhà thầu nào đi nữa, pháp luật đấu thầu đều bắt buộc phải có bước phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong quy trình đấu thầu. Với việc không tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn thầu trong trường hợp gói thầu nêu trên, bên mời thầu (ở đây là Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế - Đơn vị thuộc Bộ Y tế) đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đấu thầu về trình tự, thủ tục tiến hành đấu thầu thuốc.

2.2.2 Việc thương thảo, bảo đảm thực hiện hợp đồng

Theo Kết luận thanh tra số 2117/KL-TTCP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

---

[57] Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

[58] VCCI. (2022). *Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của Doanh nghiệp.* Hà Nội.

(thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2021) có nội dung còn tồn tại một số hạn chế trong việc thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng như sau:

- Về thương thảo hợp đồng:

Theo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản bước thương thảo, hoàn thiện hợp đồng được thực hiện sau khi phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu. Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư xem xét, lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo; trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì xem xét xử lý tình huống theo quy định.[59] Chính vì lẽ đó, thực sự việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2005 thường mang tính hình thức, phía Bên mời thầu, Chủ đầu tư thực hiện để coi như cho xong, thậm chí còn không tổ chức thương thảo mà chỉ gửi biểu mẫu, hoàn thiện hợp đồng cho xong. Về phía nhà thầu, do đã có kết quả trúng thầu nên tâm lý cầm chắc trong tay nên không coi trọng và cũng không "mặn mà" ở bước này hoặc quá trình thương thảo cũng qua loa, dẫn đến có những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu… không được phát hiện, thương thảo, thống nhất trước khi ký kết hợp đồng, có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Để khắc phục những yếu điểm của Luật Đấu thầu năm 2005, hiện tại Luật Đấu thầu quy định sau khi có Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, thì bên mời thầu phải mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên trao đổi về các nội dung như sau: *(i) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; (ii) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong hồ sơ dự thầu (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án thay thế của nhà thầu nếu trong hồ sơ mời thầu có quy định cho phép nhà thầu chào phương án thay thế; (iii) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; (iv) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác*.[60] Nếu trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng

---

[59] Điều 42 Luật Đấu thầu năm 2005.

[60] Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu.

Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra cho thấy có rất nhiều gói thầu mà ở đó chủ đầu tư không thực hiện việc thương thảo hợp đồng hoặc có tổ chức thương thảo hợp đồng nhưng lại rất sơ sài, không đầy đủ các nội dung đã liệt kê ở trên và cũng trong kết luận thanh tra này có nêu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong số 43 gói thầu mua sắm sinh phẩm thì tất cả các gói thầu này đều không thực hiện việc thương thảo hợp đồng. Đây là con số thống kê khá lớn cho thấy việc các chủ đầu tư, bên mời thầu mua sắm thuốc không thực sự quan tâm đúng mực ý nghĩa của việc tổ chức thương thảo hợp đồng.

- Về bảo đảm thực hiện hợp đồng:

Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định *"nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức từ 2% đến 10% giá hợp đồng. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức từ 2% đến 3% giá hợp đồng".* Quy định này tương đồng với nội dung trong Luật Đấu thầu cũng như Nghị định 63/2014/NĐ-CP đều đồng bộ "*nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực*".

Đồng thời, tại phục lục 7 của thông tư này (Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) cũng có quy định: *"Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Mục 6.1 ĐKCT. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu số 15 Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận."*

Như vậy, có thể hiểu bảo đảm thực hiện hợp đồng là điều khoản bắt buộc phải có trong tất cả các hợp đồng trong hợp động đấu thầu không phân biệt đó là loại hợp đồng trọn gói hay hợp đồng không trọn gói; hợp đồng được ký kết có giá trị gói thầu lớn hơn 10 tỷ hay không quá 10 tỷ. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra của Chính phủ đã nêu rõ *"hầu hết các gói thầu theo quy trình rút gọn, chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo Điều 66 Luật Đấu thầu 2013; khoản 3 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Mặc dù đa số các nhà thầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết, nhưng bên cạnh đó có một số nhà thầu chậm hoặc không cung cấp hàng hoá theo cam kết nhưng do không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng nên chủ đầu tư không thể đưa ra biện pháp xử lý về kinh tế đối với nhà thầu vi phạm. Điển hình tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều*

trị bệnh nghề nghiệp có nhà thầu là Công ty TNHH Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường và nhà thầu là Công ty TNHH TM-DV-SX-XNK Sơn Thịnh".

Có thể nhận định rằng nếu tất cả các gói thầu mua thuốc đều áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo đúng quy định đã được hướng dẫn sẽ phần nào góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu tình trạng nhà thầu vi phạm hợp đồng mà chủ đầu tư, bên mời thầu không thể áp dụng các biện pháp "trừng phạt" mang tính kinh tế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm thuốc.

2.2.3 Xác định giá gói thầu

- Vấn đề ưu đãi trong mua sắm thuốc:

Điều 50 Luật đấu thầu năm 2013 quy định: *"Việc ưu đãi trong mua thuốc được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Luật này. Đối với thuốc sản xuất trong nước được Bộ Y tế công bố đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu".* Điều này đồng nghĩa với việc nếu gói thầu mua sắm thuốc mà những loại thuốc nằm trong danh mục kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp thì chủ đầu tư phải quy định trong hồ sơ mời thầu là không chào thuốc nhập khẩu.[61] Tuy nhiên, trên thực tế các chủ đầu tư, đơn vị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc (Sở Y tế) lại không ưu tiên chọn loại thuốc (hoạt chất) có trong danh mục nêu trên.[62] Như vậy, việc chủ đầu tư chọn các mặt hàng thuốc nhập khẩu là hoàn toàn không phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu về ưu đãi trong mua sắm thuốc dẫn đến giá trị gói thầu bị cao hơn so với việc lựa chọn mặt hàng thuốc trong danh mục của Bộ Y tế.

Đối với vấn đề ưu đãi trong mua sắm thuốc, Luật Đấu thầu năm 2023 quy thay đổi so với luật hiện hành mà cụ thể như sau: *"(i) Đối với thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất đáp ứng về tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá thì chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào thuốc xuất xứ trong nước đối với mặt hàng này; (ii) Đối với thuốc được Bộ Y tế công bố có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu chỉ chào thầu thuốc xuất xứ trong nước".* So với quy định hiện hành, Luật Đấu thầu năm 2023 đã thay đổi tiêu chí ưu đãi như sau:

---

[61] Danh mục bao gồm 640 loại thuốc đạt các tiêu chí kỹ thuật WHO-GMP hoặc tiêu chí kỹ thuật EU-GMP.

[62] Thông báo Kết luận thanh tra số 2269/TB-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2021), trang 5.

+ ***Trường hợp 1,*** Chủ đầu tư được quyền tự quyết việc có yêu cầu nhà thầu chào thuốc xuất xứ trong nước hay không đối với thuốc có tối thiểu 03 nhà sản xuất trong nước đáp ứng được tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và chất lượng, giá. Điều này dẫn tới việc không bắt buộc nhà thầu phải chào thuốc xuất xứ trong nước.

+ **Trường hợp 2,** Bắt buộc chủ đầu tư yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhà thầu phải chào thuốc có xuất xứ trong nước đối với thuốc có tối thiểu 03 nhà sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương và tiêu chí về chất lượng, giá cả, khả năng cung cấp. Nhận thấy, việc quy định bắt buộc khác với việc chủ đầu tư được quyền tự quyết ở chỗ thuốc phải đáp ứng tất cả các tiêu chí của việc tự quyết và tiêu chí kỹ thuật EU-GMP, khả năng cung cấp.

- Vấn đề xác định giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc xác định giá gói thầu phải *"Tham khảo giá thuốc và dược liệu trúng thầu trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc theo nguyên tắc: Giá kế hoạch của từng thuốc, dược liệu không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc, dược liệu đó trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được công bố. Đối với những thuốc, dược liệu chưa có giá trúng thầu được công bố hoặc giá tại thời điểm lập kế hoạch cao hơn giá trúng thầu được Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) công bố trong vòng 12 tháng trước đó, cơ sở y tế phải tham khảo báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của ít nhất 03 đơn vị cung cấp trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu".*[63]

Trên thực tế thực hiện mua sắm thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh một số chủ đầu tư có tình trạng xây dựng giá gói thầu một số loại thuốc vượt giá trúng thầu cao nhất được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. Điển hình như: Hoạt chất Heparin, hàm lượng/nồng độ 25.000UI/5ml, dạng bào chế là dung dịch tiêm truyền nhóm 2 có giá trúng thầu cao nhất là 72.030 đồng/lọ trong khi đó các chủ đầu tư đều xác định giá kế hoạch của hoạt chất này là 147.000 đồng/lọ; hay đối với thuốc Paracetamol 500mg có giá trúng thầu cao nhất là 98 đồng/viên nhưng Bệnh viện Nhi đồng 1 (gói thầu mua sắm thuốc Generic mua với 100.000 gói thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà – lần 1) xây dựng giá kế hoạch là 178,5 đồng/viên; Thuốc vitamin C, hàm lượng 500mg dưới dạng bào chế là viên uống thuộc nhóm 4 với giá trúng thầu cao nhất là 168 đồng/viên thì Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh Nghề nghiệp tại gói thầu "Mua thuốc bổ sung cho một phần Bệnh viện Phục hồi chức

[63] Điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

năng – Điều trị bệnh Nghề nghiệp điều trị người bệnh COVID-19 lần 1 và lần 2" lại xây dựng giá kế hoạch là 360 đồng/viên.[64]

Nhận thấy với quy định mức "giá trần" như trên sẽ gây khó khăn cho các bệnh viện bởi nếu cứ lấy bằng hoặc thấp hơn giá trúng thầu trong vòng 12 tháng đổ lại, thì mặc nhiên giá năm sau phải thấp hơn giá năm trước và đến một thời điểm nào đó trong tương lai thì giá của hàng hóa sẽ về 0. Điều này trái ngược với quy luật thị trường là giá năm sau thường sẽ cao hơn năm trước và doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp không muốn tham gia thầu. Bên cạnh đó, vấn đề tham khảo 03 báo giá tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng gây không ít khó khăn đối với bên mời thầu bởi lẽ cũng có xuất hiện trường hợp không tìm đủ được 03 báo giá theo yêu cầu nên khó khăn cho việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ đó dẫn đến việc mua sắm thuốc bị trì hoãn và gây ra tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

Vì vậy, Thông tư số 06/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2023 sửa đổi vấn đề xác định giá gói thầu theo hướng *"Giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước hoặc trúng thầu tập trung cấp Quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được công bố trên trang Thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền). Trường hợp chưa được công bố trên trang Thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) thì căn cứ quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu hoặc thông tin công khai theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP".*[65]

Với thông tư mới, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị chỉ cần tham khảo giá thuốc trúng thầu của các cơ sở y tế hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước hoặc trúng thầu tập trung cấp quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được công bố trên trang thông tin của Bộ Y tế hoặc tham khảo 03 báo giá khác nhau tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thuốc không đủ 03 báo giá, người đứng đầu đơn vị căn cứ vào ít nhất 01 báo giá, giải trình, chịu trách nhiệm về giá kế hoạch đề xuất và bảo đảm không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo.

Ngoài ra, theo kết quả thanh tra tại Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù đa số các chủ đầu tư có tham khảo giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng của các cơ sở y tế

---

[64] Thông báo Kết luận thanh tra số 2269/TB-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2021), trang 6.

[65] Điểm b khoản 13 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

do Cục Quản lý dược, Bộ Y tế công bố trên trang thông tin điện tử và báo giá của các doanh nghiệp làm cơ sở để xây dựng đơn giá cho từng loại thuốc. Nhưng bên cạnh đó, việc xác định đơn giá thuốc của một số chủ đầu tư vẫn còn những sai phạm, thiếu sót mà cụ thể là việc xác định dải giá trúng thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, tại Phụ lục II của Phụ lục 5 (Mẫu văn bản trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc) có yêu cầu chủ đầu tư phải *"Ghi rõ dải giá trúng thầu trong vòng 12 tháng trước công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Y dược cổ truyền). Ví dụ: 2.700-3.150 (VND)/viên",* nghĩa là phải thống kê giá thuốc trúng thầu đã được công bố từ thấp nhất đến cao nhất. Nhưng theo kết quả thanh tra cho thấy Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới chỉ thống kê 01 giá thuốc cùng loại đã trúng thầu được công bố trong vòng 12 tháng của gói thầu "Mua thuốc bổ sung năm 2020 – 2021 lần 6" và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu này đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để thực hiện mua sắm thuốc. Việc lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nêu trên đã vi phạm quy định các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc.

2.2.4 Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

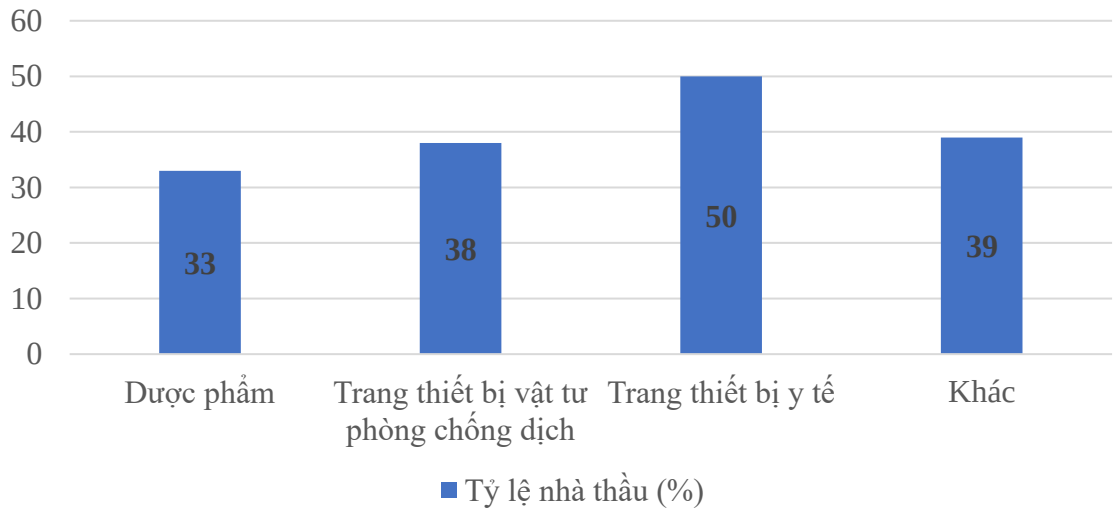
Pháp luật đấu thầu nói chung, đấu thầu thuốc nói riêng đã có những quy định chi tiết về những hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu thuốc bao gồm 09 hành vi sau đây: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; Thông thầu; Gian lận; Cản trở; Không bảo đảm công bằng, minh bạch; Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu; Chuyển nhượng thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng pháp luật về đấu thầu thuốc không ít những nhà thầu, bên mời thầu đã có những hành vi vi phạm các quy định nêu trên.

- Vấn đề "chi phí ngoài quy định":

Một vấn đề lớn thường xảy ra trong hoạt động đấu thầu có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước như đấu thầu mua sắm thuốc thì hiện tượng chi trả chi phí ngoài quy định nhằm thông đồng, cấu kết, dàn xếp hoạt động đấu thầu thuốc để tạo điều kiện cho một bên thắng thầu. Hiện tượng này làm mất đi tính cạnh tranh công bằng, khiến hoạt động đấu thầu không còn minh bạch.[66]

[66] Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam VTV1. (2021). *Lỗ hổng trong đấu thầu: Khi những "con voi chui lọt lỗ kim"*. Truy cập ngày 20/6/2023, từ https://vtv.vn/kinh-te/lo-hong-trong-dau-thau-khi-nhung-con-voi-chui-lot-lo-kim-20211031084151916.htm.

Theo kết quả Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của Doanh nghiệp ghi nhận *"Doanh nghiệp tham gia khảo sát được đặt câu hỏi về mức độ đồng ý của họ đối với nhận định chi trả hoa hồng là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu. Kết quả cho thấy khoảng 34,4% doanh nghiệp cho rằng việc chi trả hoa hồng là một yêu cầu bắt buộc để có thể trúng thầu".*[67] Nói cách khác, cứ 10 nhà thầu tham gia dự thầu thì có khoảng 03 nhà thầu sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định để gia tăng khả năng trúng thầu. Một nhà thầu tham gia khảo sát cho rằng *"Doanh nghiệp phải chi trả các khoản chi phí này để các bước chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu được trơn tru hơn. Có những trường hợp doanh nghiệp từ chối không chi trả các khoản chi phí này khiến cho tiến độ hoàn thành hồ sơ bị chậm trễ, không nộp được hồ sơ dự thầu gây tổn thất lớn hơn khoản chi trả này."* Theo đó, trong nhóm các nhà thầu tham gia dự thầu liên quan lĩnh vực y tế đồng ý với nhận định trên khá cao. Nếu phân chia nhà thầu thành các nhóm theo đặc điểm hàng hóa đã cung cấp cho thấy có tới 50% nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế đồng ý với nhận định về việc chi trả chi phí ngoài trong khảo sát để trúng thầu. Tỷ lệ này với nhóm nhà thầu cung cấp trang thiết bị vật tư phòng chống dịch và dược phẩm lần lượt là 38% và 33% và với các hàng hoá, dịch vụ khác là 39%.[68]



Hình 2.2: Tỷ lệ nhà thầu chi trả chi phí ngoài tham gia gói thầu tại Cơ sở y tế công lập

Ngoài ra, trong báo cáo còn chỉ ra được mối liên hệ mật thiết giữa việc chấp nhận chi trả chi phí ngoài với mức độ cạnh tranh của hình thức lựa chọn nhà thầu. Theo đó, các nhà thầu có xu hướng sẵn sàng chi trả "hoa hồng" nhiều hơn đối với đấu thầu hạn chế (70%) hay chỉ định thầu (51%) so với các hình thức lựa chọn nhà thầu có nhiều sự cạnh tranh, tham gia của các nhà thầu như chào hàng cạnh tranh (40%) hay đấu thầu rộng rãi (27%). Điều này cũng dễ dàng được lý giải bởi đối với những hình thức kém cạnh tranh, ít sự tham gia của nhà thầu thì việc nhà thầu phải chi trả chi phí nhằm mục

[67] VCCI. (2022). *Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của Doanh nghiệp.* Hà Nội, trang 26.

[68] VCCI. (2022). *Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của Doanh nghiệp.* Hà Nội, trang 30.

đích trúng thầu là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi việc nhà thầu chi trả khoản phát sinh này cũng không ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của nhà thầu khi trúng thầu vì đa số trong thực tế các khoản này nhà thầu đã tính vào chi phí dự thầu, vào giá trị hàng hoá nên về bản chất chi phí này chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của nhà thầu.

Để lý giải cho hành vi chi trả các khoản "chi phí ngoài" có thực sự xuất phát tự việc nhà thầu "tự nguyện" hay do có sự gợi mở, hướng dẫn từ phía bên mời thầu, trong Báo cáo cũng có đặt câu hỏi khảo sát: *"Việc chi trả chi phí ngoài quy định là do bên nào chủ động?"* thì câu trả lời nhận được là do nhà thầu chủ động, do cán bộ phụ trách đấu thầu của bên mời thầu, chủ đầu tư gợi ý, thậm chí còn được hiểu ngầm là luật bất thành văn phải tự hiểu khi tham gia đấu thầu. Sau khi đối chiếu, thống kê câu trả lời cho kết quả tỷ lệ nhà thầu chủ động đưa chi phí ngoài để dàn xếp việc đấu thầu lên tới 32,8%; có tới 21,3% doanh nghiệp trả lời do cán bộ phụ trách đấu thầu, chủ đầu tư gợi ý và tỷ lệ cao nhất trong số câu trả lời cho rằng việc chi trả chi phí ngoài là luật bất thành văn khi tham gia dự thầu chiếm tỷ trọng 50,8%.

Tỷ lệ càng cao, cho thấy mức độ phổ biến của hành vi này trong hoạt động đấu thầu thuốc càng lớn và đây là một vấn đề hết sức cần phải chú ý. Trên thực tế, trong thời gian sau đại dịch vừa qua mà điển hình là những tháng cuối năm 2022 đầu năm 2023 hàng loạt vụ án liên quan đến đấu thầu thuốc, vật tư y tế được xem là những vụ "trọng án" với số tiền lên đến hàng tỷ đô la. Hành vi đưa, nhận "chi phí ngoài" trong đấu thầu thuốc được xem là hành vi bị nghiêm cấm, đây là những hành vi gây mất tính cạnh tranh lành mạnh và làm giảm hiệu quả của hoạt động đấu thầu.

- Vấn đề đảm bảo công bằng trong đấu thầu thuốc:

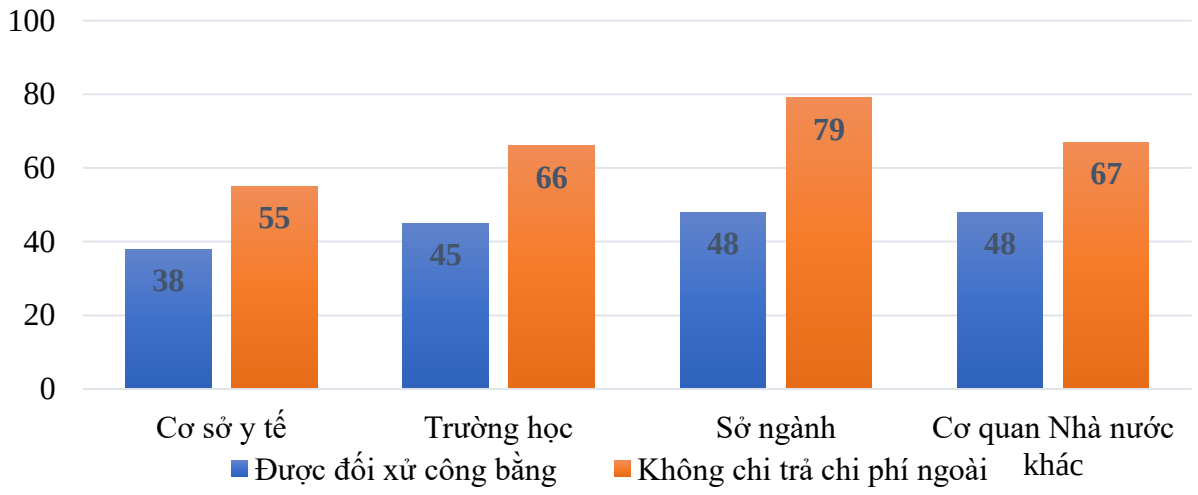
Công bằng, minh bạch là những nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu thuốc của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, điều này càng quan trọng hơn khi mà các Hiệp định Việt Nam đã ký kết, chưa là thành viên đều quy định nguyên tắc này hết sức chặt chẽ và phải được nghiêm túc tuân thủ. Theo khảo sát năm 2021 có đề nghị nhà thầu đánh giá về sự công bằng trong ứng xử của đơn vị bên mời thầu tại các địa phương. Cụ thể, đó là câu hỏi về việc liệu *"trong quá trình tham gia đấu thầu, nhà thầu có được cơ quan mời thầu đối xử công bằng so với các bên tham gia đấu thầu khác không?"*. Kết quả nhận được khoảng 38% doanh nghiệp đánh giá bên mời thầu là các cơ sở ý tế đã đối xử công bằng, điều này có nghĩa là khoảng 62% nhà thầu nhận định đã không được đối xử công bằng so với các nhà thầu còn lại. Nếu so sánh với bên mời thầu khác như Trường học, các Sở ngành, hay Cơ quan nhà nước khác thì tỷ lệ này cao hơn từ 43% đến 48%.

Cũng theo Báo cáo, nhóm chuyên gia nhận định rằng có sự liên quan giữa việc nhà thầu đánh giá được đối xử công bằng với tỷ lệ nhà thầu không chi trả chi phí ngoài quy định. Theo đó, ở những gói thầu ít xảy ra tình trạng trả chi phí ngoài quy định hơn

thì dường như tình trạng ưu ái đối xử giữa nhà thầu này với nhà thầu khác cũng ít hơn và ngược lại ở những gói thầu có tỷ lệ nhà thầu chi trả chi phí ngoài cao thì kết quả trả lời không được đối xử bình đẳng cũng cao theo.

Nếu xét trên phương diện nhóm ngành hàng thì 31% nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế, 33% nhà thầu cung cấp dược phẩm, 33% nhà thầu cung cấp trang thiết bị vật tư phòng chống dịch và 51% nhà thầu khác nhận định rằng được bên mời thầu đối xử công bằng. Điều này đồng nghĩa với việc gần 70% nhà thầu cung cấp thuốc cho rằng học không được đối xử như đúng kỳ vọng. Và kết quả cũng chỉ ra rằng các nhà thầu chưa hài lòng với nguyên tắc không phân biệt đối xử trong đấu thầu này đa số là các nhà thầu có quy mô siêu nhỏ và mới hoạt động trong vòng 05 năm gần nhất.

Đương nhiên, phân tích này cũng chỉ rõ mối quan hệ giữa mức độ đối xử công bằng với hình thức lựa chọn nhà thầu. Cũng tương tự như vấn đề chi phí ngoài quy định, đối với hình thức đấu thầu càng có sự cạnh tranh, tham gia nhiều nhà thầu thì mức độ đánh giá công bằng được cao hơn so với các hình thức đấu thầu kém cạnh tranh còn lại. Cụ thể, khoảng 54% nhà thầu đánh giá được đối xử công bằng khi tham gia gói thầu đấu thầu rộng rãi; 43% nhà thầu hài lòng về sự đối xử với nhà thầu khác khi tham gia gói thầu chào hàng cạnh tranh. Trong khi đó, hình thức đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thì tỷ lệ này khá thấp dao động từ 30% đến 39%.

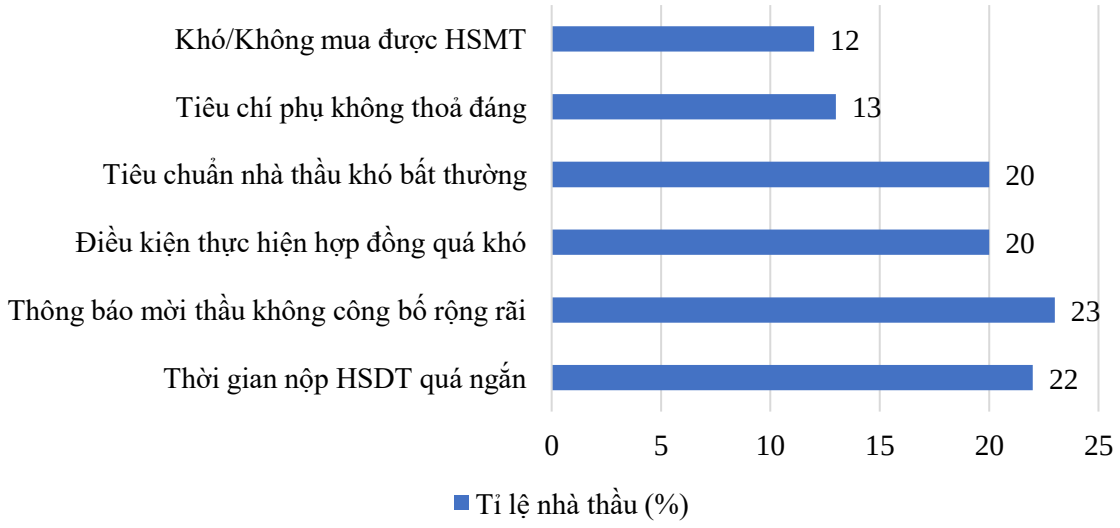


Hình 2.3: Mối tương quan giữa đối xử công bằng và không chi trả chi phí ngoài theo Bên mời thầu

2.2.5 Một số vấn đề khác

Ngoài các vấn đề đã được đề cập ở trên, trong Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của Doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đã chỉ ra những trải nghiệm của nhà thầu khi tham gia các hoạt động đấu thầu, mua sắm công tại địa

phương. Trong đó, các nhà thầu tham gia đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập cho rằng còn tồn tại một số hiện tượng cần khắc phục trong thời gian tới như tình trạng thời gian nộp hồ sơ dự thầu quá ngắn. Giá trị này là cao nhất khi so với các nhóm nhà thầu tham gia gói thầu được chào bởi các cơ sở công lập hay đơn vị nhà nước khác. Tương tự, đều có khoảng 20% nhà thầu đồng ý rằng điều kiện thực hiện hợp đồng quá khó và tiêu chuẩn nhà thầu khó bất thường. Khoảng 12% nhà thầu phản ánh khó hoặc không thể mua được hồ sơ mời thầu.



Hình 2.4: Một số hiện tượng thường gặp khi nhà thầu tham gia đấu thầu tại Cơ sở y tế công lập

- Đối với vấn đề thời gian nộp hồ sơ dự thầu quá ngắn, thông báo mời thầu không công bố rộng rãi hay nhà thầu gặp khó khăn hoặc không mua được hồ sơ mời thầu: Như đã phân tích ở phần công bố thông tin đấu thầu, Luật Đấu thầu hiện có quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu và thời gian thông Tuy nhiên, có trường hợp bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu trễ hơn thời gian quy định dẫn đến việc thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị rút ngắn hơn so với quy định của Luật dẫn đến khả năng nhà thầu không hoàn thành được hồ sơ và mất cơ hội tham dự gói thầu. Bên cạnh đó, vấn đề phát hành hồ sơ mời thầu khi nhà thầu cử đại diện đến mua hồ sơ dự thầu mặc dù có đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách nhà thầu (Giấy giới thiệu, Căn cước công dân) nhưng vẫn còn gặp tình trạng "nhũng nhiễu", gây khó dễ như thông báo rằng hồ sơ mời thầu đã được bán hết và đang phát hành thêm, cán bộ thực hiện nhiệm vụ đi vắng,…. Hiện nay, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đã khắc phục được hạn chế này bằng cách quy định *"Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu. Trường hợp bán hồ sơ mời thầu (bản điện tử đã phát hành trên Hệ thống) thì khi nộp*

hồ sơ dự thầu nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu".

- Đối với vấn đề tiêu chí phụ, điều kiện thực hiện hợp đồng hay các điều kiện về nhà thầu khó bất thường: Lý giải cho vấn đề này có thể nói đến việc chủ đầu tư cố tình "cài cấm" các điều khoản về năng lực, kinh nghiệm, các tiêu chí hợp đồng thực hiện tương tự của nhà thầu được xây dựng trong hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho nhà thầu "quân xanh" hay các điều kiện bảo quản thuốc vượt quá tiêu chuẩn so với tiêu chuẩn thông thường. Điều này dẫn đến việc một số nhà thầu tham gia mặc dù đã đáp ứng được yêu cầu của gói thầu (nếu chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu một cách công tâm) không thể đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu và từ đó làm cho mục đích của việc đấu thầu thuốc không đạt được, giảm tính cạnh tranh, không mang lại sự công bằng.

2.3 Kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu thầu thuốc

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: (i) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; (ii) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Theo đó, một trong các đột phá chiến lược mà Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu ra là: *"Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật"*.[69] Như vậy, qua gần 10 năm thực hiện Luật Đấu thầu đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, cần thiết phải đổi mới để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước thông qua đấu thầu.

[69] Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2021.

2.3.1 Xác định đối tượng điều chỉnh phù hợp với nguồn vốn

- Phương án 1, Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đấu thầu dựa trên một số cơ sở như sau: *Thứ nhất,* xét trên cơ sở lý luận thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị trực tiếp quản lý quỹ bảo hiểm y tế vì vậy Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng vai trò là chủ đầu tư sẽ phù hợp với tính chất quản lý nguồn vốn. *Thứ hai,* xét trên cơ sở thực tiễn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc thí điểm đấu thầu tập trung cấp quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. Cụ thể tại Điều 7 có quy định *"Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc thí điểm giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc giá do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu) theo quy định. Giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu. Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu theo quy định."*

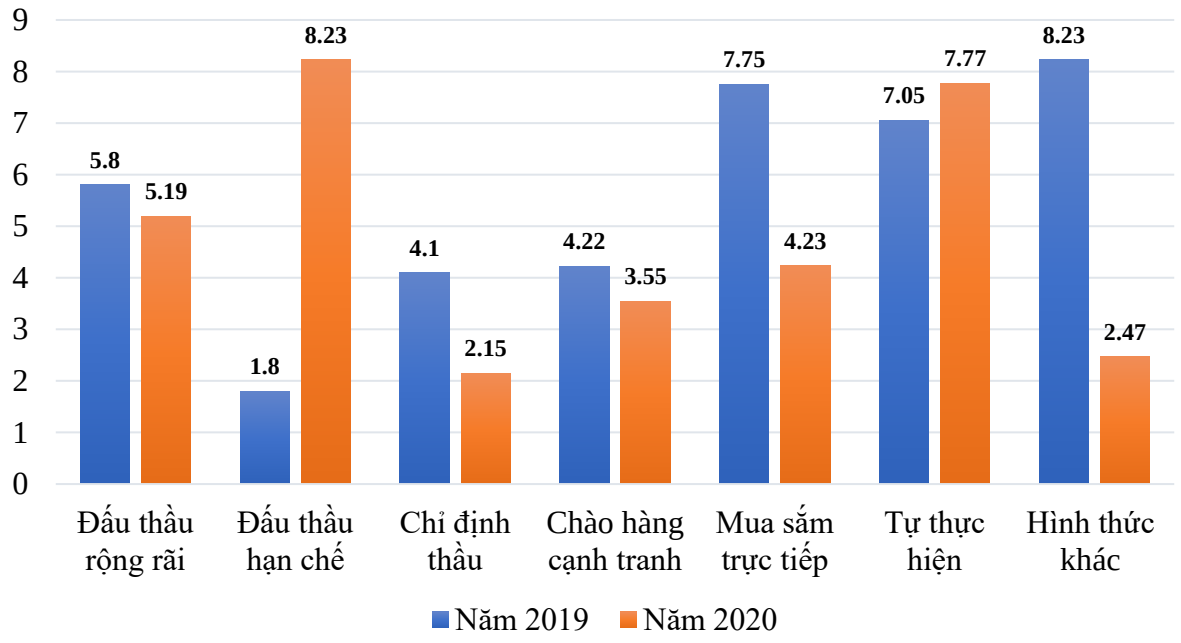
- Phương án 2, tiến hành sửa đổi khái niệm chủ đầu tư trong Luật Đấu thầu theo hướng bổ sung chủ đầu tư là đơn vị mua sắm tập trung. Như vậy, lúc này dù cho trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể hiện nguồn vốn từ quỹ bảo hiểm y tế hay bất kỳ nguồn vốn nào khác theo quy định thì cơ sở khám, chữa bệnh dù không phải là đơn vị không có sẵn nguồn vốn vẫn được xem là chủ đầu tư. Theo đó, khái niệm chủ đầu tư nên được sửa lại như sau: *"Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn, quản lý quá trình thực hiện dự án; đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng dự toán mua sắm ngoài ngân sách nhà nước; đơn vị mua sắm tập trung".*

2.3.2 Quy định cụ thể trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Sau thời gian dài áp dụng Luật Đấu thầu cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn ra là có một nghịch lý vô cùng lớn. Mặc dù pháp luật đấu thầu đã có quy định các trường hợp được tiến hành đấu thầu tại Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2013, tuy nhiên, trong lúc cần áp dụng hình thức chỉ định thầu thì lại chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể như thế nào là "cấp bách" để thực hiện. Mãi cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP và Nghị quyết số 86/NQ-CP thì vướng mắc trên mới được giải quyết. Tuy nhiên, sau khi có hướng dẫn áp dụng thì xuất hiện tình trạng một số bên mời thầu thực hiện tổ chức đấu thầu chậm trễ hơn so với thời gian quy định dẫn đến thiếu thuốc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Trong khi đó, có tình trạng một số bên mời thầu lợi dụng quy định pháp luật về chỉ định thầu tiến hành chia nhỏ gói thầu thành nhiều gói thầu khác nhau với mục đích được chỉ

định thầu đối với các nhà thầu "thân hữu" mà không hướng đến mục đích công bằng, hiệu quả kinh tế theo đúng nghĩa của đấu thầu.

Theo Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 07 hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt) thì trong giai đoạn 2015-2020, chỉ định thầu là hình thức được áp dụng nhiều nhất và có tỷ lệ tiết kiệm thấp. Chỉ định thầu là hình thức kém cạnh tranh nhất trong các hình thức lựa chọn nhà thầu và cũng là hình thức mà các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ không khuyến khích áp dụng. Việc lạm dụng chỉ định thầu sẽ làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu, làm méo mó thị trường, tạo điều kiện cho tham nhũng, lãng phí phát triển. Cụ thể, chỉ tính năm 2019 và 2020 thì chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp, chỉ đạt 2,15%. Trong khi đó, đấu thầu rộng rãi là hình thức có tính cạnh tranh nhất và tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,19%.[70]



Hình 2.5: Tỷ lệ tiết kiệm chia theo hình thức lựa chọn nhà thầu (%)

Đối với hình thức chỉ định thầu, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng không mở rộng phạm vi áp dụng hình thức chỉ định thầu mà phải quy định chi tiết, cụ thể trường hợp nào được áp dụng và thực hiện theo đúng quy trình được đã quy định nhằm khắc phục được 02 thực trạng nêu trên. *Đặc biệt là nên bổ sung giải thích từ ngữ như thế nào là trường hợp cấp bách được áp dụng hình thức chỉ định thầu tại Luật Đấu thầu hoặc văn bản hướng dẫn. Định nghĩa này nên được xây dựng theo hướng giải thích được nội hàm của từ "cấp bách" và kết hợp liệt kê một số trường*

[70] Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu giai đoạn 2015-2020, trang 20.

hợp như dịch bệnh, cấp cứu người bệnh mà tại bệnh viện không có thuốc hoặc thuốc không đủ dùng,… và các trường hợp có tính cấp bách khác.

Cũng tương tự với trường hợp chỉ định thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp cấp bách cũng chưa được quy định cụ thể dẫn đến rất khó trong quá trình áp dụng. Căn cứ vào lịch sử áp dụng hình thức này, nhà làm luật cần bổ sung gói thầu *"mua thuốc, vắc xin trong quá trình thử nghiệm, có yêu cầu đặc thù của nhà sản xuất về điều kiện mua, thanh toán, bảo lãnh, bảo đảm và điều kiện khác trong quá trình thực hiện hợp đồng"* là một trong những trường hợp được áp dụng nhằm tránh bị động khi tình trạng biến động xã hội diễn ra. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến việc đấu thầu mua thuốc, vắc xin thông qua các tổ chức quốc tế. Bởi vì trên thực tiễn những năm qua một số loại hàng hóa liên quan đến y tế như vaccine, sinh phẩm, thuốc hoặc các sản phẩm chuyên biệt mà các cơ quan Liên Hợp quốc có thể mua với mức giá thấp hơn (do đặt hàng số lượng lớn cho các nước trên thế giới) so với đấu thầu trong nước.[71] Tuy nhiên, hoạt động này gặp nhiều khó khăn do thiếu quy định của pháp luật. Vì vậy, việc bổ sung trường hợp này vào hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt là hợp lý.

2.3.3 Sửa đổi quy trình đấu thầu thuốc, đấu thầu thuốc qua mạng

Từ nhiều năm qua, các quốc gia trên thế giới đã và đang ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử để cung cấp các dịch vụ công của chính phủ. Theo ước tính, giá trị mua sắm công chiếm từ 10%-25% GDP của mỗi quốc gia, vì vậy việc triển khai đấu thầu, mua sắm công qua mạng luôn được xem là một trong những ưu tiên của chính phủ các nước khi thực hiện chương trình Chính phủ điện tử và thực tế đã mang lại nhiều lợi ích cho chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp (nhà thầu) và người dân.[72] Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung cả năm 2020 đấu thầu qua mạng giúp tiết kiệm khoảng 1.725 tỷ đồng chi phí hành chính trực tiếp, cụ thể: (i) Đối với chủ đầu tư, bên mời thầu: thời gian lựa chọn nhà thầu qua mạng (từ khi phát hành hồ sơ mời thầu đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu) so với đấu thầu truyền thống trung bình tiết kiệm được 6 ngày, quy đổi theo chi phí tiền lương/ngày công là khoảng trên 500 tỷ đồng; (ii) Đối với nhà thầu: theo khảo sát, các doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu qua mạng tiết kiệm được 5 triệu đồng chi phí hành chính (bao gồm chi phí mua hồ sơ mời thầu, chi phí đi lại, in ấn, nhân công) so với đấu thầu truyền thống. Trong năm 2020, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khoảng 98.000 gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng, số lượng nhà thầu

---

[71] Lan Hương. (2022). *Sửa đổi Luật Đấu thầu phải đánh giá toàn diện, sâu sắc những vướng mắc, bất cập trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế*. Truy cập ngày 26/6/2023, từ https://quochoi.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=68651.

[72] Hoàng Cương. (2021). Đổi mới công tác đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế và Dự báo.*

trung bình tham dự một gói thầu qua mạng là 2,5 nhà thầu/gói thầu. Như vậy, số chi phí hành chính mà nhà thầu tiết kiệm được lên tới 1.225 tỷ đồng[73].

Mục đích của đấu thầu thuốc là tìm ra được nhà thầu cung cấp thuốc có năng lực về kinh nghiệm, tài chính đáp ứng đủ tiêu chí của gói thầu để cung ứng thuốc theo kỳ vọng với mức giá tối ưu nhất so với các nhà thầu cùng tham gia dự thầu. Vì thế, việc tiết kiệm chi phí là một trong những vấn đề lớn cần được quan tâm. Để thực hiện được mục tiêu trên, theo quan điểm cá nhân người viết cần phải quy định cụ thể quy trình đấu thầu thuốc qua mạng vào Luật Đấu thầu, thời gian trong đấu thầu thuốc truyền thống cũng như các bước thẩm định khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cần được tinh chế lại cho phù hợp với thực tế, cụ thể như sau:

- ***Thứ nhất,*** cần quy định cụ thể quy trình đấu thầu qua mạng nói chung và đấu thầu thuốc qua mạng nói riêng vào trong Luật Đấu thầu sửa đổi. Bởi lẽ, hiện nay Luật Đấu thầu chưa có quy định về quy trình đấu thầu hay đấu thầu thuốc qua mạng mà những nội dung này lại được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong khi đó, kể từ giai đoạn thử nghiệm, vận hành đến hiện nay ở hầu hết các khâu, các giai đoạn của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gần như được thực hiện đầy đủ như đăng tải thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu lên Hệ thống, nộp hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu,… Thêm vào đó, việc áp dụng quy định về đấu thầu thuốc qua mạng đang ngày càng trở nên phổ biến theo đúng lộ trình mà nhà làm luật mong muốn, việc vận hành Hệ thống cũng khá ổn định và mang lại hiệu quả rất tích cực.

Việc quy định quy trình đấu thầu thuốc qua mạng vào Luật Đấu thầu sửa đổi không chỉ có ý nghĩa thể hiện việc quan tâm đúng mực của Nhà nước đối với việc đổi mới Hệ thống dịch vụ điện tử phù hợp với xu hướng Thế giới, thích ứng với sự phát triển Các mạng công nghệ 4.0 mà còn giúp cho người nghiên cứu, chủ thể áp dụng pháp luật, chủ thể khác có liên quan dễ dàng tìm kiếm thông tin quy định pháp luật. Hiện nay, quy trình đấu thầu thuốc qua mạng đang được quy định rãi rác ở các văn bản quy phạm pháp luật của nhiều cơ quan (Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế) như Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư số 06/2023/TT-BYT. Đối với cùng một vấn đề đấu thầu thuốc qua mạng nhưng lại được quy định ở nhiều văn bản khác nhau của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau sẽ phần nào gây khó khăn cho người dân trong việc tìm kiếm các quy định, việc hệ thống hoá các quy định với nhau,… Vì thế, việc quy định chung về một văn bản có giá trị pháp lý cao như Luật Đấu thầu là hợp lý, vừa thể hiện được tầm quan trọng của đấu thầu thuốc qua mạng và vừa giúp người dân dễ dàng hệ thống hoá quy định về đấu thầu thuốc qua mạng.

---

[73] Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu giai đoạn 2015-2020.

- ***Thứ hai,*** rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và lược bỏ việc thẩm định, phê duyệt ở các bước trung gian. Theo đó, Luật Đấu thầu cần sửa đổi theo hướng *"bỏ thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, điều chỉnh các mốc thời gian cho phù hợp đối với một số công việc do được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quy định thống nhất, cụ thể các mốc thời gian tối đa, tối thiểu cho từng chủ thể tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng vẫn bảo đảm các mục tiêu cơ bản của công tác đấu thầu"*.

Việc lược bỏ một số thủ tục và quy định các mốc thời gian tối đa, tối thiểu được tinh giản hơn so với quy định hiện hành sẽ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả Nhà nước, chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu. Theo đó, Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2013 có quy định về việc các trường hợp được chỉ định thầu nhưng vẫn đủ có thể áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác thì cần nên được rút ngắn thời gian hơn so với quy định khung thời gian của hình thức lựa chọn nhà thầu đã được áp dụng. Bởi lẽ, về bản chất những gói thầu này mang tính cấp bách, có nguy cơ gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư hay cấp thiết để phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, pháp luật đã cho phép chỉ định thầu để rút ngắn thời gian đấu thầu nhằm tránh những thiệt hại to lớn hơn. Nhưng khi bên mời thầu đã lựa chọn hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh cao hơn (có thể là chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi,…) thì không nhất thiết phải áp dụng các quy định về thời gian của các hình thức đấu thầu đó vì như thế sẽ kéo dài thời gian thực hiện của gói thầu.

Bên cạnh đó, cần tối đa hóa việc thực hiện các thủ tục đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như kê khai về năng lực, kinh nghiệm để tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất về nhà thầu. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện nay còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật do việc phát triển trên nền tảng công nghệ của Hệ thống KONEPS do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ từ năm 2009 nên người dùng còn gặp một số trở ngại khi thao tác nghiệp vụ về đấu thầu thuốc qua mạng trên Hệ thống như chỉ tương thích với trình duyệt Internet Explorer. Vì vậy, cần nâng cấp các tác vụ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thay cho việc phải thực hiện trực tiếp như hiện nay như: thực hiện bảo lãnh dự thầu online, đánh giá hồ sơ dự thầu tự động (từng bước Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động đánh giá và đưa ra kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện việc phê duyệt các hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thay cho thẩm định, phê duyệt trực tiếp như hiện nay, ký kết hợp đồng qua mạng,… lựa chọn danh sách nhà cung cấp kèm theo danh mục thuốc và các điều kiện về kỹ thuật, giao hàng, bảo hành để công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở để bên mời thầu tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng ngay với nhà cung cấp mà không cần phải tổ chức đấu thầu gây mất thời gian từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu mua sắm thuốc.

2.3.4 Sửa đổi quy định hình thức hợp đồng trọn gói

Như đã phân tích ở phần thực trạng quy định pháp luật về hình thức hợp đồng, hiện tại Luật Đấu thầu quy định đối với gói thầu mua sắm thuốc có quy mô nhỏ (không quá 10 tỷ) sẽ phải áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói để ký kết hợp đồng mà không được phép lựa chọn bất kỳ hình thức nào khác. Trong khi đó, do tính chất đặc thù của gói thầu cung cấp thuốc, số lượng thuốc sử dụng trong năm phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân nên thông thường số lượng thuốc sử dụng thực tế khác so với số lượng thuốc ghi trong hợp đồng. Do đó, hình thức hợp đồng trọn gói đối với gói thầu mua sắm thuốc có quy mô nhỏ là chưa thực sự hợp lý.

Trước thực trạng quy định pháp luật về hình thức hợp đồng trọn gói không phù hợp với gói thầu mua sắm thuốc quy mô nhỏ, cần phải thay đổi quy định về hình thức hợp đồng này như sau:

- ***Phương án 1,*** loại bỏ quy định về gói thầu mua sắm thuốc quy mô nhỏ ra khỏi điểm c khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu. Lúc này điều khoản này được quy định như sau: *"Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói, trừ gói thầu mua thuốc"*

- ***Phương án 2,*** Xác định lại điều kiện áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Theo đó, nên xây dựng theo hướng được áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói khi mà *"các điều kiện về kỹ thuật, phạm vi thực hiện công việc, thời gian thực hiện hợp đồng hay là khối lượng công việc phải thực hiện không có sự biến động hoặc ít có khả năng thay đổi".*

2.3.5 Tuyên truyền pháp luật và nâng cao chất lượng nhân sự đấu thầu

Theo quan sát của người viết trong quá trình nghiên cứu đề tài, việc công tác đấu thầu thuốc chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn (mặt bằng cạnh tranh chưa cao; còn nhiều phản hồi từ phía doanh nghiệp nhận định thiếu sự công bằng, minh bạch; tỷ lệ tiết kiệm vẫn còn thấp ở một số hình thức lựa chọn nhà thầu) hay thậm chí là có nhiều trường hợp vi phạm pháp luật đấu thầu nghiêm trọng dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự mà báo chí đã đăng tin trong suốt thời gian qua. Mà một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tế trên có một tỷ lệ nhân sự thực hiện công tác đấu thầu chưa nắm rõ các quy định của pháp luật.

Vì vậy, ngoài các giải pháp về thay đổi các quy định pháp luật về đấu thầu thuốc, thì theo quan điểm của người viết cũng cần phải tích cực phổ biến các quy định pháp

luật về đấu thầu thuốc, đặc biệt là thời gian sắp tới khi mà Luật Đấu thầu năm 2023 sắp có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2024) khi mà Luật này có nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung (trong đó có không ít sự thay đổi của quá trình tổ chức đấu thầu thuốc). Đối tượng hướng đến của việc phổ biến pháp luật đấu thầu là cán bộ trực tiếp thực hiện công việc đấu thầu thuốc ở các cơ sở y tế, Sở Y tế. Ngoài nhóm đối tượng chính yếu này, thì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu thầu thuốc cũng cần thực hiện đối với các doanh nghiệp có liên quan hoạt động cung ứng thuốc. Việc lựa chọn nhóm đối tượng này bởi một số lý do:

- Thứ nhất, nhóm đối tượng này có thể không phải là người nghiên cứu về luật bởi chuyên môn của họ là lĩnh vực y khoa.

- Thứ hai, họ là người trực tiếp thực hiện công việc nên bổ sung kiến thức pháp luật là điều hết sức cần thiết.

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu thầu thuốc, hoạt động cũng quan trọng khác là nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện công tác đấu thầu. Để thực hiện biện pháp này, thì các cơ quan chủ quan cơ sở y tế ở địa phương (Sở Y tế) nên tạo điều kiện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ hoặc theo nhu cầu thực tế.

2.3.6 Đánh giá khả năng tác động của giải pháp

- Khi sửa đổi quy trình đấu thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu sẽ góp phần làm giảm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc tiết kiệm thời gian trong đấu thầu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc đưa gói thầu tiến hành sớm, tiết kiệm chi phí cho các bên tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu như chi phí lương chuyên gia đấu thầu, chi phí hành chính khác.

- Việc quy định cụ thể các hình thức lựa chọn nhà thầu và điều kiện áp dụng của từng hình thức, đặc biệt là chỉ định thầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong đấu thầu trong quá trình áp dụng quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần hạn chế theo hướng thu hẹp việc áp dụng hình thức đấu thầu kém cạnh tranh là chỉ định thầu. Đồng thời, tăng cường việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

- Việc sửa đổi các quy định về hình thức hợp đồng trọn gói sẽ tạo sự phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Ngoài ra, việc sửa đổi góp phần giải quyết được các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng qua đó hạn chế các chi phí phát sinh như chi phí xử lý tình huống.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Thông qua việc phân tích các quy định pháp luật về đấu thầu thuốc, có thể kết luận như sau: Hành lang pháp lý về đấu thầu thuốc hiện nay đáp ứng cơ bản được nhu cầu mua sắm thuốc, có những nội dung quy định phù hợp với thực tiễn và ngày càng được quan tâm sửa đổi như đấu thầu thuốc qua mạng, xác định giá trong kế hoạch lựa

chọn nhà thầu. Bên cạnh đó cũng có những nội dung chưa thực sự phù hợp với đời sống xã hội cần phải được sửa đổi, loại bỏ kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu thuốc. Ngoài các bất cập về quy định của pháp luật thì vẫn còn tồn tại một số thực trạng về việc thực hiện pháp luật đấu thầu thuốc chưa đúng mặc dù pháp luật đã có quy định và quy định rất cụ thể.

Từ những bất cập, thực trạng đã được rút ra sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để khắc phục nhằm hướng đến tạo môi trường đấu thầu thuốc lành mạnh, cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

KẾT LUẬN

Đấu thầu nói chung và đấu thầu thuốc nói riêng là lĩnh vực tương đối khó tiếp cận ngay cả khi đối với người được trang bị kiến thức về pháp luật. Bởi sự đa dạng của các hình thức mua sắm, các quy định về quy trình, các biểu mẫu, thủ tục khá phức tạp đòi hỏi người thực hiện công tác đấu thầu thuốc phải nắm vững các nền tảng cơ bản của quy định pháp luật và không ngừng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu. Qua thời gian nghiên cứu đề tài *"Pháp luật về đấu thầu thuốc"* người viết đã thu được những kết quả sau đây:

Thông qua việc phân tích cơ sở lý luận pháp luật về đấu thầu thuốc, đã làm rõ được các khái niệm đấu thầu thuốc thông qua việc phân tích khái niệm đấu thầu và định nghĩa về thuốc từ đó nêu lên cách thức phân loại đấu thầu thuốc cũng như làm nổi bật vai trò của đấu thầu thuốc. Từ những khái niệm cơ bản được phân tích, người viết đã tiến hành phân tích một cách tổng quát những nội dung cơ bản của pháp luật về đấu thầu thuốc nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể đến đọc giả dễ hình dung nhất đối với đề tài. Bên cạnh đó, người viết cũng đã phân tích những nội dung liên quan về đấu thầu thuốc được các tổ chức quốc tế quy định trong các Hiệp định, các nguyên tắc hay giới thiệu khái quát pháp luật về đấu thầu thuốc ở một số nước từ đó có thể đặt trên cùng hệ quy chiếu mà so sánh xem pháp luật về đấu thầu thuốc của Việt Nam hiện tại có tiệm cận được với quy định của các nước trên thế giới hay không.

Bằng việc phân tích các quy định pháp luật như Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 15/2019/TT-BYT; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư số 06/2023/TT-BYT và một số văn bản pháp lý có liên quan. Nhận thấy, sau thời gian dài áp dụng đấu thầu nói chung và đấu thầu thuốc nói riêng có những dấu hiệu tích cực như gói thầu mua sắm thuốc tăng cả về số lượng, quy mô và tỷ lệ tiết kiệm hầu như cũng được cải thiện. Tuy nhiên, khi áp dụng các văn bản trên thực tế lại tồn tại một số bất cập như các quy định về trình tự thủ tục tổ chức đấu thầu, quy định về hình thức hợp đồng, bảo đảm thực hiện tối thiểu khối lượng 80% hợp đồng, các quy định về đấu thầu thuốc qua mạng hay quy định về các hình thức lựa chọn nhà thầu,… Quy định về vấn đề nêu trên đều cho thấy sự chưa phù hợp của pháp luật hiện hành đối với nhu cầu thực tiễn. Từ những thực trạng nêu trên, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật về đấu thầu thuốc được hoàn thiện. Theo đó, những giải pháp được nên được cân nhắc triển khai bao gồm: sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng thay đổi quy trình đấu thầu, rút ngắn thời gian tổ chức đấu thầu, thêm các tác vụ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, phân biệt rõ vai trò chủ đầu tư khi tiến hành đấu thầu thuốc bằng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, loại bỏ quy định áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói cho gói thầu mua thuốc quy mô nhỏ,…kết hợp với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực cán bộ đấu thầu.

Nhìn chung, sau quá trình nghiên cứu nhận thấy đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu ban đầu đề ra và có thể có những đóng góp trong công tác xây dựng hành lang pháp lý đấu thầu thuốc ngày càng hoàn thiện. Những đề xuất trong phần giải pháp nếu vận dụng vào quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu phần nào sẽ lấp đầy những lỗ hỏng hiện tại và quy định pháp luật về đấu thầu thuốc tiến bộ hơn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy dành cho những ai có nhu cầu nghiên cứu pháp luật về đấu thầu thuốc.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2021.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

2. Luật Thương mại năm 2005.

3. Luật Đấu thầu năm 2005 (hết hiệu lực).

4. Luật Đấu thầu năm 2013.

5. Luật Dược năm 2016.

6. Luật Đấu thầu năm 2023 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024).

7. Nghị định số 43-CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu (hết hiệu lực).

8. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

9. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

10. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

11. Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

12. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược.

13. Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

14. Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

15. Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng

7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

16. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

17. Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

18. Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

1. APEC. (2006). *Review of the APEC Non-Binding Principles (NBPs) on Government Procurement, Government Procurement Experts' Group Meeting*. Hoi An.

2. Đại học Y Hà Nội. (2007). *Dược lý học (sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa).* Hà Nội. Tr.02.

3. Hoàng Cương. (2021). Đổi mới công tác đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế và Dự báo*.

4. Hoàng Phê. (2021). *Từ điển Tiếng Việt.* Tp. Hồ Chí Minh. Nxb: Hồng Đức. Tr.381.

5. National Health Development Research Center of the National Health Commission. (2018). *2018 China Total Health Expenditure Research Report*. Beijing: Institute of health and economy press.

6. Nguyễn Duy Cương. (2005). *Từ điển Bách khoa dược học.* Hà Nội. Tr.619.

7. Nguyễn Duy Lãm. (1996). *Sổ tay Thuật ngữ pháp lý thông dụng.* Hà Nội: Nxb. Giáo dục. Tr.127.

8. Nguyễn Thị Như Nguyệt. (2022). Thực trạng công tác đấu thầu ở Việt Nam hiện nay và khuyến nghị. *Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 01 năm 2022*, Tr.02.

9. Nguyễn Việt Dũng. (2012). Kinh nghiệm đấu thầu của một số tổ chức quốc tế. *Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương* (317), trang 33.

10. Phạm Lương Sơn. (2012). *Nghiên cứu thực trạng đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập ở Việt Nam* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội).

11. Tăng Bình & Ái Phương. (2022). *Nghiệp vụ công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế và biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế*. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tài chính.

12. The World Bank. (2016). *Standard Procurement Document Request for Bids Health Sector Goods (Pharmaceuticals, Vaccines and Condoms.*

13. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2006). *Giáo trình Luật Thương mại Tập II*. Hà Nội. Nxb. Công an Nhân dân. Tr. 202.

14. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ chí Minh. (2020). *Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại (tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)*. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam. Tr.13.

15. United Nations. (2014). *UNCITRAL Model Law on Public Procurement.* New York.

16. Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp. Tr.240.

17. Vụ Công tác lập pháp. (2005). *Những nội dung cơ bản của Luật Dược*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp. Tr.19.

18. Vũ Thị Hiền. (2018). Việt Nam hướng tới tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ (GPA) của WTO: Những thách thức từ góc độ minh bạch hóa. *Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 97*.

19. Wang J *et al*. (2021). Impact of '4+7' volume-based drug procurement on the use of policy-related original and generic drugs: a natural experimental study in China. *Health policy Original research*, page 8. DOI:10.1136/ BMJOPEN-2021-054346.

20. World Trade Organization. (2012). *Agreement on Government Procurement*.

21. Xie J *et al*. (2021). The influences of national centralized drug procurement policy on drug price, cost and generic drug substitution: taking the four municipalities data. *Chinese Health Economics* (40), page. 18.

22. Zhai T *et al*. (2020). The Results and Analysis of National Health Accounts in China in 2018. *Chinese Health Economics* (39), page 5–8. DOI: 10.7664/CHE20200601.

B. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

23. Ban Nội chính Trung ương. (2020). *Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả toàn diện, thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế*. Truy cập ngày 18/12/2022, từ Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả toàn diện, thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế" - Ban Nội Chính Trung ương (noichinh.vn).

24. Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam VTV1. (2021). *Lỗ hổng trong đấu thầu: Khi những "con voi chui lọt lỗ kim"*. Truy cập ngày 20/6/2023, từ https://vtv.vn/kinh-te/lo-hong-trong-dau-thau-khi-nhung-con-voi-chui-lot-lo-kim-20211031084151916.htm.

25. Báo điện tử Chính phủ. (2022). *Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hoàn thành sớm ngày nào bà con được hưởng lợi ngày đó*. Truy cập ngày 28/4/2023, từ https://baochinhphu.vn/benh-vien-ung-buou-can-tho-hoan-thanh-som-ngay-nao-ba-con-duoc-huong-loi-ngay-do-102220516132605384.htm.

26. Chen Yang & Lei Li. (2010). *Drug Procurement Bidding*. Retrieved Mar 20, 2023, from https://www-chinabusinessreview-com.translate.goog/drug-procurement-bidding/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp.

27. Cục Quản lý dược. (2023). *Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 21/04/2023*. Truy cập ngày 30/4/2023, từ

https://dav.gov.vn/tong-hop-bao-cao-kqtt-cua-cac-don-vi-bao-cao-cap-nhat-den-ngay-21042023-n3929.html.

28. Dương Liễu. (2022). *40 bệnh viện, sở y tế trên cả nước báo cáo thiếu thuốc*. Truy cập ngày truy cập 21/03/2023, từ https://tuoitre.vn/40-benh-vien-so-y-te-tren-ca-nuoc-bao-cao-thieu-thuoc-20220629190635123.htm.

29. General Office of the State Council of the People's Republic of China. (2019). *Pilot Program for National Centralized Drug Procurement and Use*. Retrieved Apr 25, 2023, from http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-01/17/content_5358604.htm.

30. Hiền Minh. (2023). *Bộ trưởng Bộ Y tế nêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2023*. Truy cập ngày 25/4/2023, từ https://baochinhphu.vn/bo-truong-y-te-neu-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-y-te-nam-2023-102230224095937745.htm.

31. Joint Procurement Office. (2018). *Bid-winning results of "4+7" city centralized drug procurement*. Retrieved Apr 19, 2023, from http://www.smpaa.cn/gjsdcg/2018/12/17/8580.shtml.

32. Joint Procurement Office. (2018). *The results of 4+7 city drug centralized procurement*. Retrieved Apr 25, 2023, from http://www.smpaa.cn/gjsdcg/2018/12/07/8531.shtml.

33. Lan Hương. (2022). *Sửa đổi Luật Đấu thầu phải đánh giá toàn diện, sâu sắc những vướng mắc, bất cập trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế*. Truy cập ngày 26/6/2023, từ https://quochoi.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=68651.

34. Võ Hoàng Quân. (2014). *Vai trò của đấu thầu đối với hiệu quả chi tiêu công.* Truy cập ngày 25/04/2023, từ https://tapchitaichinh.vn/vai-tro-cua-dau-thau-doi-voi-hieu-qua-chi-tieu-cong.html.

C. TÀI LIỆU KHÁC

35. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Đấu thầu (sửa đổi).

36. Báo cáo số 1528/BC-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế về thực trạng tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

37. Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu giai đoạn 2015-2020.

38. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2021). *Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020*.

39. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới. (2016). *Báo cáo Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ*.

40. Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu trên cả nước.

41. Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

42. Chỉ thị số 20/CT-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế.

43. Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016.

44. Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

45. Nghị quyết số 86 ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

46. Quyết định số 5239/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

47. Thông báo Kết luận thanh tra số 2269/TB-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2021).

48. Thông báo Kết luận thanh tra số 2323/TB-TTCP ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế.

49. Thông báo Kết luận thanh tra số 218/TB-TTCP ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021.

50. VCCI. (2022). *Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của Doanh nghiệp.* Hà Nội.

PHỤ LỤC[74]

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hoá chất và trang thiết bị y tế

(Số liệu thống kê từ báo cáo các đơn vị gửi về)

STT	ĐƠN VỊ THIẾU	THUỐC	VẬT TƯ, HOÁ CHẤT	TRANG THIẾT BỊ
A	**Bộ Y tế**			
1	Bệnh viện mắt TW	0	Có thiếu cục bộ	0
2	Bệnh viện 71 TW	4	1	0
3	Bệnh viện ĐK Cần Thơ	0	68	0
4	Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam	Có thiếu	Có thiếu	0
5	Bệnh viện C Đà Nẵng	55	366	Có thiếu
B	**Sở Y tế Đồng Nai**			
1	Bệnh viện ĐK Thống Nhất	1	57	4
2	BVĐK Đồng Nai	12	38	0
3	TTYT huyện Vĩnh Cửu	4	0	4
4	TTYT huyện Tân Phú	3	2	0
5	TTYT huyện Thống Nhất	2	0	0
6	Bệnh viện Nhi Đồng	6	0	0
7	TTYT huyện Xuân Lộc	3	0	0
8	TTYT huyện Cẩm Mỹ	15	0	0
9	Bệnh viện ĐKKV Long Khánh	44	4	1
10	Bệnh viện ĐKKV Long Thành	0	19	0
11	TTYT Trảng Bom	0	12	0
C	**Sở Y tế Lâm Đồng**			
1	Bệnh viện ĐK Lâm Đồng	23	40	0
2	Bệnh viện II Lâm Đồng	0	118	0
3	TTYT Đà Lạt	10	0	0

[74] Báo cáo số 1528/BC-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế về thực trạng tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

D	**Sở Y tế Đắk Lắk**			
1	Bệnh viện ĐKKV Tây Nguyên	28	27	0
E	**Sở Y tế Sóc Trăng**			
1	Bệnh viện ĐK Sóc Trăng	25	69	5
2	TTYT Trần Đề	7	2	0
G	**Sở Y tế Thái Nguyên**			
1	Bệnh viện A	0	11	0
2	Bệnh viện Mắt	1	0	0
3	TTYT TP. Sông Công	1	0	0
4	Bệnh viện ĐK huyện Thịnh Hóa	2	0	0
H	**Sở Y tế Đà Nẵng**			
1	Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng	Có thiếu cục bộ	Có thiếu cục bộ	0
2	TTYT Liên Chiểu	Có thiếu	50	0
I	**Sở Y tế Thanh Hoá**			
1	Bệnh viện ĐK tỉnh Thanh Hoá	7	15	0
2	Bệnh viện ĐK Bỉm Sơn	11	17	0
K	**Sở Y tế Nghệ An**	Có thiếu cục bộ	Có thiếu cục bộ	Có thiếu cục bộ
L	**Sở Y tế Hà Tĩnh**	69	177	0
M	**Sở Y tế Quảng Bình**	Có thiếu	Có thiếu	Có thiếu
N	**Sở Y tế Quảng Trị**	0	Có thiếu	Có thiếu
O	**Sở Y tế Thừa Thiên Huế**	Có thiếu	0	0
P	**Sở Y tế Quảng Nam**	Có thiếu	Có thiếu	0
Q	**Sở Y tế Quảng Ngãi**	Có thiếu	Có thiếu	0
R	**Sở Y tế Bình Định**	0	Có thiếu	0
S	**Sở Y tế Khánh Hòa**	0	629	0
T	**Sở Y tế Ninh Thuận**	Có thiếu cục bộ	Có thiếu	Có thiếu
U	**Sở Y tế Bình Thuận**	Có thiếu	Có thiếu	0